

Anno Accademico 2025-2026

Docente: Dott.ssa Sonia Montemurro

Corso di Laurea: Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro

Università degli Studi di Padova

INDICE

PARTE A - FONDAMENTI EPISTEMOLOGICI

1. Il Quadro Epistemologico
2. Salute e Sanità: Distinzione Epistemologica
3. La Concezione Dialogica di Salute

PARTE B - DAL MODELLO MEDICO ALLA PSICOPATOLOGIA

4. Storia ed Evoluzione del Modello Medico
5. Il Modello Operativo Medico
6. La Nascita della Psicopatologia
7. I Sistemi di Classificazione: DSM e ICD
8. Disturbi Mentali Specifici
9. Modelli Alternativi: HiTOP e RDoC

PARTE C - STRUMENTI OPERATIVI E APPLICAZIONI

10. Il Colloquio Clinico
 11. Valutazione Psicologica
 12. Il Modello Operativo Dialogico
 13. Architettura dei Servizi Generativa
 14. Capacità di Intendere e Volere
 15. Contesti Applicativi
-

INTRODUZIONE AL CORSO

Il corso di **Psicologia Clinica per la Salute** si propone di offrire strumenti di fondazione epistemologica, teorici e metodologici per lo studio della Psicologia Clinica in riferimento al costrutto di "Salute". L'obiettivo principale è fornire una comprensione approfondita delle basi epistemologiche della disciplina, degli strumenti operativi per la promozione della salute

in diversi contesti (clinico, organizzativo, comunitario), e delle metodiche di diagnosi e valutazione.

Articolazione del Corso

Il corso si struttura in **tre sezioni principali**:

a) I fondamenti epistemologici della Psicologia Clinica e del costrutto di Salute

- Riflessione epistemologica e livelli di realismo
- Il principio di indeterminatezza e l'avvento dei paradigmi integrazionistici
- La suddivisione delle scienze: adozione di un linguaggio e produzione degli asserti
- Descrizione filologica ed epistemologica di Salute

b) Strumenti operativi per la promozione della salute

- Dal modello medico alla nascita della psicopatologia
- La prassi diagnostica e l'avvento delle tassonomie (DSM, ICD)
- La proposta di un modello operativo per la Psicologia clinica per la Salute
- La configurazione dialogica di Salute
- Dall'Architettura della cura (nomotetica) ad un'Architettura di Servizi generativa di Salute

c) Metodiche di diagnosi organizzativa e valutazione

- Diagnosi organizzativa
- Valutazione del rischio di infortunio
- Valutazione dell'efficienza gestionale
- Capacità di intendere e volere

PARTE A - FONDAMENTI EPISTEMOLOGICI DELLA PSICOLOGIA CLINICA E DEL COSTRUTTO DI SALUTE

1. IL QUADRO EPISTEMOLOGICO

1.1 Livelli di Realismo

L'epistemologia della Psicologia Clinica si fonda sulla comprensione dei diversi livelli di realismo attraverso cui osserviamo e conosciamo la realtà. Questi livelli rappresentano modalità diverse di accesso alla conoscenza e implicano concezioni differenti del rapporto tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto.

Realismo Monista

Il realismo monista presuppone l'esistenza di una **realtà oggettiva, unica e indipendente dall'osservatore**, conoscibile attraverso l'indagine empirica diretta. È il livello proprio delle scienze naturali classiche e della medicina tradizionale.

Caratteristiche:

- **Locus dell'osservazione:** l'osservato (l'Unità Anatomo-Funzionale nella medicina)
- **Ontologia:** la realtà esiste indipendentemente dall'osservatore
- **Epistemologia:** la conoscenza è una rappresentazione fedele della realtà oggettiva
- **Metodologia:** metodo sperimentale, misurazione quantitativa
- **Paradigma:** meccanicistico-causale
- **Forma dell'asserto:** leggi universali espresse in linguaggi formali

Implicazioni per la pratica clinica: Nel contesto medico tradizionale, la malattia è vista come un'alterazione oggettiva dell'Unità Anatomo-Funzionale (UAF), rilevabile attraverso segni oggettivi (semeion) indipendenti dalla percezione soggettiva del paziente o dall'interpretazione del clinico.

Realismo Concettuale

Il realismo concettuale riconosce che **la conoscenza è sempre mediata da costrutti teorici e modelli interpretativi**. La realtà è accessibile attraverso i concetti e le categorie che utilizziamo per descriverla.

Caratteristiche:

- **Locus dell'osservazione:** parzialmente spostato verso l'osservatore e i suoi strumenti concettuali
- **Ontologia:** la realtà esiste ma è accessibile solo attraverso mediazioni concettuali
- **Epistemologia:** la conoscenza è costruzione teorica guidata da modelli interpretativi
- **Metodologia:** uso di costrutti teorici, operazionalizzazione di concetti
- **Linguaggio:** mix di linguaggio ordinario e formale
- **Validità:** dipende dalla coerenza interna del sistema concettuale e dalla sua utilità pragmatica

Implicazioni per la pratica clinica: In psicologia, i costrutti come "intelligenza", "personalità", "salute mentale" non sono entità direttamente osservabili ma costruzioni teoriche che guidano l'osservazione e l'intervento. La diagnosi diventa un processo di categorizzazione basato su criteri concettuali condivisi dalla comunità scientifica.

Realismo Ipotetico

Il realismo ipotetico considera la realtà come **il prodotto dell'interazione tra osservatore e osservato**, mediata dal linguaggio e dai processi dialogici. La conoscenza è sempre situata, contestuale e co-costruita.

Caratteristiche:

- **Locus dell'osservazione:** l'interazione osservatore-osservato
- **Ontologia:** la realtà emerge nell'interazione, non esiste indipendentemente da essa
- **Epistemologia:** la conoscenza è co-costruzione dialogica
- **Metodologia:** analisi dei processi discorsivi, studio delle configurazioni di senso
- **Paradigma:** narrativistico-interazionista
- **Forma dell'asserto:** configurazioni discorsive, non leggi universali

Implicazioni per la pratica clinica: La salute diventa una configurazione di senso che emerge dal dialogo tra lo narrante, Esperto e Matrice Collettiva. Non è un dato oggettivo da rilevare, ma una realtà che si costruisce nel processo stesso di osservazione e intervento. Il clinico non è un osservatore neutrale ma un co-costruttore attivo della realtà clinica.

1.2 Evoluzione dei Paradigmi Scientifici

La storia della scienza mostra un'evoluzione progressiva dei paradigmi, ciascuno caratterizzato da una specifica **nozione centrale** e da un determinato approccio alla conoscenza. Questa evoluzione non è un semplice progresso lineare, ma rappresenta cambiamenti profondi nel modo stesso di concepire il rapporto tra conoscenza e realtà.

Quadro Sinottico dei Paradigmi

Periodo	Paradigma	Nozione Centrale	Forma Asserto	Senso	Caratteristiche
Pre-1543	Percettivistici	Percetto	-logos	Comune	Basati sulla percezione diretta
Pre-1543	Spiritualistici	Spirito	-logos	Comune	Introducono dimensione spirituale
1543-1905	Meccanicistici	Causa	-nomos, -ica	Scientifico	Legge di causa-effetto, misura
1905-1927	Relativistici	Energia	-ica	Scientifico	Relatività spazio-temporale
1927-oggi	Interazionistici	Interazione	-ica	Scientifico	Principio di indeterminatezza

1. Paradigmi Percettivistici (Senso Comune)

Epoca: Pre-scientifica

Nozione centrale: Percetto (ciò che è immediatamente percepito)

Forma dell'asserto: -logos (negazione del linguaggio formale)

I paradigmi percettivistici rappresentano il modo di conoscenza pre-scientifico, basato sulla **percezione diretta e immediata**. La conoscenza è ciò che appare ai sensi, senza

mediazioni concettuali o strumentali.

Caratteristiche:

- Conoscenza basata sull'esperienza sensoriale immediata
- Assenza di distinzione tra dato percettivo e dato osservativo
- Mancanza di un linguaggio formalizzato
- Validazione attraverso il senso comune condiviso

Esempio: "Il sole gira intorno alla terra" è un'affermazione percettivistica: descrive ciò che si percepisce direttamente, non ciò che si osserva attraverso strumenti e teorie.

2. Paradigmi Spiritualistici (Senso Comune)

Epoca: Pre-scientifica

Nozione centrale: Spirito

Forma dell'asserto: -logos

Introducono la dimensione dello **spirito** come principio esplicativo, ma mantengono una forma dell'asserto non formalizzata. Rappresentano un tentativo di andare oltre la pura percezione, introducendo entità non direttamente osservabili.

Caratteristiche:

- Introduzione di entità metafisiche (anima, spirito, essenze)
- Spiegazioni basate su principi vitali
- Linguaggio ordinario, non formalizzato
- Validazione attraverso autorità e tradizione

Esempio in medicina: La teoria degli "umori" di Ippocrate, che spiegava salute e malattia attraverso il bilanciamento di quattro umori (sangue, flegma, bile gialla, bile nera) corrispondenti a qualità spirituali.

3. Paradigmi Meccanicistici (1543-1905)

Data di inizio: 1543 - Rivoluzione copernicana ("De revolutionibus orbium coelestium" di Copernico)

Nozione centrale: Causa (noxa causalis)

Forma dell'asserto: -nomos (legge), -ica (tecnica applicativa)

La **rivoluzione copernicana** segna l'inizio della scienza moderna. Il passaggio fondamentale è la **distinzione tra dato percettivo (ciò che appare ai sensi) e dato osservativo (ciò che emerge dall'uso di linguaggi formali e strumenti)**.

Caratteristiche fondamentali:

- **Distinzione cruciale:** percezione diretta vs osservazione mediata da strumenti e teorie

- **Linguaggi formali:** matematica, fisica, chimica permettono la misura
- **Causalità lineare:** ogni effetto ha una causa specifica e identificabile
- **Determinismo:** date le condizioni iniziali, il sistema è prevedibile
- **Riduzionismo:** il complesso è spiegabile attraverso le parti semplici
- **Oggettività:** l'osservatore può essere neutrale rispetto all'osservato

Impatto sulla medicina: Nasce il concetto di **noxa causalis** (causa nociva): ogni malattia ha una causa specifica identificabile. Questo paradigma è alla base del modello medico che vedremo nella Parte B.

Principio dello "spiegare": Morgagni (1761) - attraverso l'anatomia patologica si può risalire dalla malattia alla sua causa anatomica.

Principio del "calcolare": Broussais - la patologia è quantificazione della fisiologia (continuum quantitativo tra normale e patologico).

Esempi:

- Identificazione dei batteri come cause di malattie specifiche (Koch)
- Localizzazione cerebrale delle funzioni psichiche
- Leggi della fisica newtoniana

Limiti:

- Difficoltà con fenomeni complessi e multi-causali
- Impossibilità di spiegare l'influenza dell'osservatore sull'osservato
- Riduzione della complessità umana a meccanismi causali

4. Paradigmi Relativistici (1905-1927)

Data di inizio: 1905 - Teoria della Relatività Ristretta di Einstein

Nozione centrale: Energia ($E = mc^2$)

Forma dell'asserto: -ica

Einstein introduce una rivoluzione: **tempo e spazio non sono assoluti ma relativi all'osservatore**. La velocità della luce è l'unico assoluto.

Caratteristiche:

- Relatività di spazio e tempo rispetto al sistema di riferimento
- Equivalenza massa-energia
- Rottura del determinismo assoluto
- Inizio del riconoscimento del ruolo dell'osservatore

Implicazioni filosofiche:

- La realtà dipende dal punto di osservazione

- Non esiste un'unica descrizione "vera" indipendente dall'osservatore
- Preparazione concettuale al paradigma interazionista

Limiti per le scienze umane: Pur riconoscendo la relatività dell'osservatore, mantiene l'idea di leggi universali e mantiene la separazione tra osservatore e osservato.

5. Paradigmi Interazionistici/Integrazionistici (1927-presente)

Data di inizio: 1927 - Principio di Indeterminatezza di Heisenberg

Nozione centrale: Interazione

Forma dell'asserto: -ica

Il **principio di indeterminatezza** di Werner Heisenberg costituisce la svolta epistemologica fondamentale per le scienze umane e la psicologia clinica.

Il Principio di Indeterminatezza: Non è possibile conoscere simultaneamente con precisione arbitraria sia la **posizione** che la **quantità di moto** (velocità × massa) di una particella:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$$

dove:

- Δx = indeterminatezza sulla posizione
- Δp = indeterminatezza sulla quantità di moto
- h = costante di Planck

Significato profondo: Questa non è una limitazione tecnica degli strumenti di misura, ma una **proprietà intrinseca della natura**: l'atto stesso di misurare una grandezza modifica necessariamente l'altra. **L'osservatore non può essere separato dall'osservato.**

Caratteristiche fondamentali:

- **Interazione osservatore-osservato:** l'osservazione modifica il sistema osservato
- **Incerteza costitutiva:** l'indeterminatezza non è un limite da superare ma una caratteristica intrinseca della realtà
- **Complementarità:** aspetti diversi della realtà possono essere complementari (entrambi veri) ma non simultaneamente osservabili
- **Configurazioni temporanee:** la realtà si manifesta in configurazioni che emergono dall'interazione
- **Processo prima di sostanza:** la realtà è processo più che cosa

Implicazioni per la Psicologia Clinica:

1. **Sul piano ontologico:** La "salute" non esiste come entità indipendente dall'osservazione, ma emerge nel processo di interazione tra clinico e paziente

2. **Sul piano epistemologico:** Non possiamo conoscere la "vera" condizione del paziente senza modificarla attraverso il processo stesso di conoscenza
3. **Sul piano metodologico:**
 - Il colloquio clinico non è un metodo neutro di raccolta dati, ma un processo che co-costruisce la realtà clinica
 - La diagnosi non descrive una realtà pre-esistente ma partecipa a un processo interpretativo
4. **Sul piano etico:** Il clinico è responsabile non solo di "descrivere" ma di "co-costruire" la realtà del paziente

1.3 Il Principio di Indeterminatezza e le sue Implicazioni Profonde

Dall'Indeterminatezza Quantistica all'Interazione Dialogica

Il passaggio dal paradigma meccanicistico a quello interazionista non è un semplice aggiustamento tecnico, ma una **rivoluzione epistemologica** che cambia radicalmente il modo di concepire:

- La natura della realtà
- Il processo di conoscenza
- Il rapporto osservatore-osservato
- La possibilità di previsione e controllo

Caratteristiche dell'Interazione

L'**interazione** è un processo diacronico (che si sviluppa nel tempo) di diversa tipologia attraverso cui si generano configurazioni o assetti. Può essere:

1. Interazione Energetica

- Fisica, chimica
- Governata da leggi quantitative esprimibili in linguaggi formali
- Esempio: reazioni chimiche, fenomeni elettromagnetici

2. Interazione Metabolica

- Biologica, fisiologica
- Governata da leggi biologiche e biochimiche
- Esempio: processi cellulari, metabolismo

3. Interazione Dialogica

- Psicologica, sociale, culturale
- Governata da regole d'uso del linguaggio ordinario
- Esempio: conversazione, costruzione di significati condivisi

Proprietà fondamentali dell'interazione:

- **Incerteza intrinseca:** l'interazione nel suo manifestarsi è caratterizzata da incertezza

- **Stabilizzazione temporanea:** trova assetti che tendono a stabilizzarsi
- **Distinguibilità:** diventa distinguibile e denominabile in un Linguaggio
- **Circolarità:** ogni assetto stabilizzato diventa ulteriore elemento che genera incertezza
- **Emergenza di regole:** alcuni assetti, nella loro apparente stabilità costante, possono essere considerati cause che permettono di esprimere regole o leggi

Scenario senza possibilità di previsione

L'interazione produce uno **scenario senza possibilità di previsione deterministica**. Non perché manchi informazione, ma perché l'incertezza è costitutiva del processo stesso.

Questo ha implicazioni radicali:

- **Non esistono leggi universali** per i processi dialogici
- **Non è possibile prevedere con certezza** l'esito di un'interazione
- **Ogni configurazione è unica e irripetibile** (momento Kairologico)
- **La conoscenza è sempre situata e contestuale**

1.4 La Suddivisione delle Scienze: Linguaggio e Asserti

Le scienze si distinguono fondamentalmente per:

1. Il **tipo di linguaggio** utilizzato
2. La **forma degli asserti** che producono
3. Il **livello di realismo** a cui operano

Linguaggio Ordinario

Caratteristiche:

- Utilizzato dalla comunità dei parlanti
- Il **valore delle unità simboliche si manifesta nell'uso** (pragmatica del linguaggio)
- Va oltre al significato lessicale: dipende dal contesto d'uso
- **Polisemico:** lo stesso termine può avere significati diversi in contesti diversi
- **Ambiguo:** permette molteplici interpretazioni
- **Flessibile:** si adatta alle situazioni comunicative

Possibilità operative:

- **Conta (enumerazione):** posso contare quante volte un termine appare
- **Calcola:** posso fare operazioni su frequenze, percentuali
- **NON misura:** non posso attribuire valori numerici stabili e universali

Scienze che lo utilizzano:

- Psicologia clinica dialogica

- Sociologia qualitativa
- Antropologia culturale
- Linguistica pragmatica
- Ermeneutica

Esempio in psicologia clinica: Quando un paziente dice "mi sento depresso", il significato di questa espressione non è riducibile a un valore numerico sulla scala BDI, ma emerge dal contesto narrativo complessivo, dalla storia personale, dal momento della vita, dalla relazione terapeutica.

Linguaggi Formali

Caratteristiche:

- **L'uso viene formalizzato a priori per convenzione**
- Corrisponde a **regole di applicazione predefinite**
- **Univoco:** ogni simbolo ha un significato preciso e stabile
- **Non ambiguo:** una sola interpretazione possibile
- **Rigido:** le regole sono fisse

Possibilità operative:

- **Conta**
- **Calcola**
- **Misura:** può attribuire valori numerici stabili e confrontabili

Scienze che lo utilizzano:

- Matematica
- Fisica
- Chimica
- Statistica
- Medicina (per alcuni aspetti)

Esempio in medicina: La pressione arteriosa misurata in mmHg è un linguaggio formale: 120/80 significa sempre la stessa cosa, indipendentemente dal contesto, dalla persona che misura, dal momento storico.

Implicazioni per la Distinzione Sanità/Salute

Questa distinzione linguistica è fondamentale per comprendere la differenza tra:

SANITÀ (Linguaggi Formali):

- Pressione arteriosa in mmHg
- Glicemia in mg/dl

- Conta dei globuli bianchi
- Temperatura corporea in °C
- Presenza/assenza di segni patologici identificabili

SALUTE (Linguaggio Ordinario):

- "Mi sento in forma"
- "Ho energia per affrontare la giornata"
- "Mi sento bene con me stesso"
- "Riesco a realizzare i miei progetti"
- Configurazione discorsiva di benessere

1.5 Prodotto di Regola

Un **prodotto di regola** è un prodotto astratto espresso e descritto in un Linguaggio (ordinario o formale) che:

1. **Governa l'incertezza** caratteristica delle configurazioni generate in un processo (energetico, metabolico, dialogico)
2. **Produce configurazioni** generabili in tale processo

Tipologie:

Tipo di Regola	Linguaggio	Operazioni Possibili	Esempio
Regola in linguaggio ordinario	Ordinario	Conto, calcolo	"Alzare la mano per prendere la parola"
Regola in linguaggio formale	Formale	Conto, calcolo, misura	$F = ma$ (seconda legge di Newton)

Caratteristiche delle regole:

- Emergono dall'osservazione di configurazioni che si stabilizzano
- Permettono di **anticipare** (non prevedere deterministicamente) scenari futuri
- Sono sempre **revisibili** sulla base di nuove osservazioni
- Nel caso del linguaggio ordinario, dipendono dal contesto culturale

Esempio in psicologia clinica: La "regola" secondo cui in un colloquio clinico è utile iniziare con domande aperte non è una legge universale, ma un prodotto di regola emerso dall'esperienza clinica, espresso in linguaggio ordinario, che governa (orienta) la pratica clinica ma può essere modificato in base al contesto specifico.

2. SALUTE E SANITÀ: DISTINZIONE EPISTEMOLOGICA

La distinzione tra **Sanità** e **Salute** non è semantica o terminologica, ma **epistemologica**: rappresenta due modi radicalmente diversi di concettualizzare e operare sul benessere umano, basati su paradigmi, realismi e linguaggi differenti.

2.1 Distinzione Fondamentale: Schema Comparativo

DIMENSIONE	SANITÀ	SALUTE
Locus	Osservato (UAF)	Osservatore (Logos)
Realismo	Monista	Concettuale/Ipotetico
Nozione centrale	Causa (noxa causalis)	Processo/Interazione
Paradigma	Meccanicistico	Narrativistico/Interazionista
Indicatore	Semeion (segno oggettivo)	Tekmerion (segno interpretabile)
Determinazione	Presenza/assenza noxa causalis	Valore d'uso del Logos
Definizione	A priori	Sul processo
Rilevabilità	Empiricamente	Discorsivamente
Expertise	Asimmetrica (esperto)	Dialogica (tutti esperti)
Sapere	Preleva (tradizione)	Genera (interazione)
Padronanza	Tecnica	Processo
Centralità	Istituzione	Comunità
Intervento	Prevenzione	Promozione
Strumenti	Campagne informative	Politiche pubbliche

2.2 Approfondimento: SANITÀ

Fondamento Epistemologico

La **sanità** si fonda sul paradigma meccanicistico e sul realismo monista. Presuppone che:

- Esista uno stato di "normalità" anatomo-funzionale oggettivo
- Le deviazioni da questo stato siano causate da agenti patogeni identificabili (noxa causalis)
- Sia possibile rilevare queste deviazioni attraverso segni oggettivi (semeion)
- L'intervento consista nell'eliminare o neutralizzare la causa

Il Semeion (Segno Oggettivo)

Il **semeion** è un segno oggettivo, rilevabile empiricamente, indipendente dall'interpretazione:

- Febbre a 39°C

- Pressione arteriosa 180/110
- Presenza di batteri nell'esame colturale
- Frattura ossea visibile alla radiografia
- Glicemia a 300 mg/dl

Caratteristiche:

- **Oggettività:** esiste indipendentemente dall'osservatore
- **Misurabilità:** esprimibile in linguaggi formali
- **Universalità:** ha lo stesso significato in ogni contesto
- **Dicotomia:** presente/assente

La Noxa Causalis

La **noxa causalis** (causa nociva) è l'agente patogeno che determina l'alterazione dell'UAF:

- Virus, batteri, parassiti
- Traumi fisici
- Sostanze tossiche
- Carenze nutrizionali
- Alterazioni genetiche

Logica causale:

Noxa Causalis → Alterazione UAF → Semeion → Diagnosi → Terapia (eliminazione noxa)

Implicazioni Operative

1. **Anamnesi:** ricerca della noxa causalis nella storia del paziente
2. **Diagnosi:** identificazione dell'alterazione attraverso semeion
3. **Terapia:** eliminazione o neutralizzazione della causa
4. **Prognosi:** previsione del decorso basata sulla conoscenza della causa
5. **Prevenzione:** evitare l'esposizione alla noxa causalis
6. **Valutazione efficacia:** RCT (trial clinico randomizzato controllato)

2.3 Approfondimento: SALUTE

Fondamento Epistemologico

La **salute** si fonda sul paradigma interazionista e sul realismo ipotetico. Presuppone che:

- Non esista uno stato di "normalità" assoluto e universale
- La salute sia una **configurazione di senso** che emerge dall'interazione
- Questa configurazione sia rilevabile attraverso il linguaggio (logos)

- Il valore emerge dall'**uso contestuale** del logos

Il Tekmerion (Segno Interpretabile)

Il **tekmerion** è un segno interpretabile, che acquisisce significato nel contesto d'uso:

- "Mi sento bene"
- "Ho energia"
- "Riesco a fare ciò che desidero"
- "Mi sento in equilibrio"
- "Sono soddisfatto della mia vita"

Caratteristiche:

- **Soggettività situata:** dipende dal contesto e dalla storia personale
- **Interpretabilità:** richiede comprensione del contesto narrativo
- **Particolarità:** il significato varia tra persone e contesti
- **Gradualità:** non è presente/assente ma oscilla su un continuum

Il Valore d'Uso del Logos

La configurazione di senso della salute dipende dal **valore d'uso del Logos**, cioè da come il linguaggio viene effettivamente utilizzato nel contesto specifico dell'interazione.

Esempio: La stessa espressione "sto bene" può significare:

- Per un atleta: "ho raggiunto il picco di forma fisica"
- Per un anziano: "non ho dolori invalidanti"
- Per chi è uscito da una depressione: "riesco ad alzarmi e affrontare la giornata"
- Per un malato terminale: "sono in pace con me stesso"

Il **valore** non è intrinseco alle parole, ma emerge dall'**uso** nel contesto dialogico specifico.

Il Momento Kairologico

La salute, intesa come configurazione di senso generata dal tekmerion, è soggetta alla **regola dell'ostensione**: ogni configurazione è:

1. **Unica e irripetibile** (momento Kairologico)
2. **Ha un valore compreso tra 0 e 1** (mai assoluto)
3. **Non è replicabile con certezza** in momenti diversi
4. **Dipende dal contesto dialogico** specifico
5. **Oscilla continuamente** in base all'interazione

Implicazione: La probabilità che due persone abbiano lo stesso valore di salute è teoricamente nulla, perché ogni configurazione dipende da:

- Storia individuale (Io narrante)
- Sapere esperto disponibile (Esperto)
- Contesto socio-culturale (Matrice Collettiva)
- Momento specifico dell'interazione

2.4 Evoluzione Storica del Concetto di Salute

Definizione OMS 1948

"La Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l'assenza di malattia o infermità."

Elementi innovativi:

1. **Diritto fondamentale:** la salute viene riconosciuta come diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzioni
2. **Superamento del dualismo:** viene superata la visione puramente biologica (mente-corpo)
3. **Multidimensionalità:** introduce tre dimensioni (fisica, mentale, sociale)

Criticità epistemologiche:

1. **"Stato":** cosa si intende per "stato"? Uno stato è qualcosa che cambia nel tempo, quindi come può essere "completo"?
2. **"Completo":** cosa significa "completo"? Per definire cosa è completo sarebbe necessaria una statistica di riferimento, ma quale?
3. **"Benessere":** non viene data una definizione di benessere. È soggettivo? Oggettivo? Chi lo determina?
4. **Livelli di realismo mescolati:**
 - Fisico → realismo monista (misurabile oggettivamente)
 - Mentale → realismo concettuale (costrutti psicologici)
 - Sociale → realismo ipotetico (relazioni, contesti)

Come integrare tre livelli ontologicamente diversi?

5. **"Non meramente l'assenza di malattia":** formula negativa (dice cosa NON è, ma non dice chiaramente cosa È)

Dichiarazione di Alma Ata (OMS 1978)

"La salute, che è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l'assenza di malattia o infermità, è un fondamentale diritto umano e che il conseguimento del più alto livello possibile di salute è il più importante obiettivo sociale del mondo intero, la cui realizzazione richiede l'azione di molti altri settori ed economici in aggiunta a quello sanitario."

Elementi aggiuntivi fondamentali:

1. Distinzione Salute/Sanità:

- La sanità (settore sanitario) ingloba ma non esaurisce la salute
- La salute richiede l'azione di più settori (housing, educazione, lavoro, ambiente)

2. Nascita dell'assistente sociale:

- Figura professionale che protegge il diritto alla salute
- Opera nell'intersezione tra sistemi (sanitario, sociale, educativo)

3. Cambio di paradigma:

- Da meccanicistico a **interazionistico**
- Da realismo monista a **realismo ipotetico**

4. Determinanti sociali della salute:

- La salute non dipende solo da fattori biomedici
- È determinata da condizioni socio-economiche, culturali, ambientali

Ottawa Charter for Health Promotion (1986)

Pur non facendo parte del programma, vale la pena menzionare che la Carta di Ottawa introduce il concetto di **promozione della salute** come:

"Il processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla."

Cinque aree di azione:

1. Costruire politiche pubbliche per la salute
2. Creare ambienti favorevoli
3. Rafforzare l'azione della comunità
4. Sviluppare abilità personali
5. Riorientare i servizi sanitari

2.5 Filologia del Termine "Salute"

Etimologia

Latino: *salus, salutis* = salvezza, incolumità, integrità, salute

Radice: affine a *salvus* = salvo, intero, non danneggiato

Dizionario Treccani

1. **Letterario:** "Salvezza, soprattutto come stato di benessere, di tranquillità, d'integrità, individuale o collettiva"
2. **Medico-scientifico:** "Lo stato di benessere individuale, espressione di normalità anatomo-funzionale dell'organismo considerato nel suo insieme. Il concetto di salute non corrisponde alla semplice assenza di malattie e di deficit funzionali, ma esprime la

condizione positiva di efficienza psicofisica. Fattori biologici, psicologici, culturali e sociali concorrono alla formazione e alla preservazione della complessiva situazione di benessere."

Analisi Filologica

La radice *sal-* rimanda a:

- **Integrità:** non frammentato, non lesionato
- **Salvezza:** preservazione dal pericolo
- **Completezza:** mantenimento dell'unità

Interessante:

- Il saluto "salve!" significa letteralmente "sta bene!", "sii salvo!"
- "Salutare" = augurare salute
- La parola mantiene una **connotazione positiva** (non solo assenza di male)

2.6 Conseguenze Operative della Distinzione

Nella Pratica Medica (Sanità)

Obiettivo: eliminare la malattia

Focus: l'Unità Anatomo-Funzionale

Metodo: diagnosi → terapia causale

Ruolo dell'esperto: detentore del sapere scientifico

Ruolo del paziente: portatore di sintomi/segni

Successo: eliminazione dei segni patologici

Esempio:

- Paziente con polmonite batterica
- Diagnosi: identificazione del batterio (semeion)
- Terapia: antibiotico specifico (eliminazione noxa causalis)
- Guarigione: scomparsa febbre, normalizzazione esami

Nella Pratica Psicologica Clinica (Salute)

Obiettivo: promuovere benessere e funzionamento

Focus: la configurazione discorsiva della persona nel suo contesto

Metodo: co-costruzione dialogica di sensi e possibilità

Ruolo dell'esperto: facilitatore di processi, co-costruttore

Ruolo della persona: esperto della propria esperienza

Successo: generazione di nuove configurazioni discorsive più adattive

Esempio:

- Persona con "vissuto depressivo"
 - Sinesi: raccolta della configurazione discorsiva attuale
 - Scepsi: osservazione delle modalità discorsive prevalenti
 - Dieghesia: co-costruzione di configurazioni alternative
 - Successo: ampliamento del repertorio discorsivo, maggiore agency
-

3. LA CONCEZIONE DIALOGICA DI SALUTE

3.1 Fondamenti della Scienza Dialogica

La **Scienza Dialogica** ha come campo di applicazione i **processi discorsivi**, ovvero l'insieme delle modalità di conoscenza che si generano nell'impiego del **linguaggio ordinario**. Queste modalità vanno a:

- **Generare** configurazioni di realtà
- **Costruire** significati condivisi
- **Mantenere** strutture di senso

imponentesi come **reali nei loro effetti pragmatici** per il senso comune (le affermazioni).

Definizione di Interazione

Interazione: processo diacronico di diversa tipologia (energetico, metabolico, dialogico) mediante il quale si generano, a partire da due o più elementi a loro volta generati dal medesimo processo (precedentemente o contemporaneamente), **assetti/configurazioni** in cui gli elementi possono o non possono essere più distinguibili.

Tipologie di Interazione:

1. **Energetica:**
 - Fisica, chimica
 - Es: reazione chimica, campo elettromagnetico
2. **Metabolica:**
 - Biologica, fisiologica
 - Es: digestione, respirazione cellulare
3. **Dialogica:**
 - Linguistica, sociale, psicologica
 - Es: conversazione, costruzione di significati

Caratteristiche dell'Interazione

1. **Incertezza intrinseca:** caratteristica costitutiva, non eliminabile
2. **Stabilizzazione temporanea:** nel manifestarsi, trova assetti che tendono a stabilizzarsi

3. **Distinguibilità linguistica:** diventa distinguibile e denominabile in un Linguaggio
4. **Generazione continua di incertezza:** ogni assetto stabilizzato interagisce con il tutto e diventa ulteriore elemento che genera incertezza
5. **Emergenza di regole:** alcuni assetti stabili possono essere considerati cause che permettono di esprimere regole o leggi

Formula concettuale:

Incertezza → Interazione → Assetto temporaneo → Regola → Nuova incertezza

Scenario senza possibilità di previsione

L'interazione produce uno scenario **senza possibilità di previsione deterministica**. Non è un limite tecnico, ma una caratteristica ontologica del processo stesso.

Implicazioni:

- Non esistono leggi universali per i processi dialogici
- Ogni interazione è unica e situata
- La conoscenza è sempre provvisoria e contestuale
- L'intervento partecipa alla costruzione della realtà

3.2 Prodotto di Regola

Definizione: Prodotto astratto espresso e descritto in un Linguaggio (ordinario o formale) che:

1. **Governa** l'incertezza caratteristica delle configurazioni generate in un processo
2. **Produce** configurazioni generabili in tale processo

Regola in Linguaggio Ordinario

- Possibilità: **conto** e **calcolo** (NON misura)
- Esempio: "Alzare la mano per chiedere la parola"
- Caratteristiche:
 - Contestuale
 - Interpretabile
 - Flessibile
 - Negoziabile

Regola in Linguaggio Formale

- Possibilità: conto, calcolo e **misura**
- Esempio: $F = ma$ (seconda legge di Newton)
- Caratteristiche:

- Universale
- Non ambigua
- Rigida
- Non negoziabile

3.3 La Dimensione Discreta e la Sovrapposizione

In Dialogica non è possibile separare il **Linguaggio** (osservatore) dal suo **uso** (osservato) come quantità minima di generazione di una realtà di senso.

Quanti Minimi di Senso

L'uso del Linguaggio procede per **quant minimi di senso**, collocandosi in una **dimensione discreta**:

Caratteristiche dei quanti:

- **Finiti**: ogni quanto ha un'estensione definita
- **Distinguibili**: ogni quanto è identico solo a sé stesso
- **Discreti**: non esistono valori intermedi
- **Validi**: ogni quanto è autosufficiente nel suo contesto

I quanti minimi di senso:

- Sono le "particelle" che costituiscono la **materia discorsiva**
- Interagiscono costantemente in modo indeterminato e casuale
- Sono in **stato di sovrapposizione** fino all'osservazione

Superposition (Sovrapposizione)

Analogia con la meccanica quantistica:

Prima dell'osservazione:

- I quanti minimi di senso sono in **sovrapposizione**
- Tutti i significati possibili coesistono
- L'incertezza è massima

Durante l'osservazione:

- La massa di quanti "prende forma"
- Si manifesta in uno o più **Repertori Discorsivi**
- La configurazione assume statuto di "realtà di fatto"

Dopo l'osservazione:

- I quanti ritornano in sovrapposizione

- Nuove configurazioni diventano possibili
- Il processo ricomincia

Implicazione cruciale: La configurazione osservata non è LA realtà, ma UNA possibile configurazione tra le molte potenziali. L'atto di osservazione seleziona una configurazione tra le molte possibili.

3.4 Repertori Discorsivi

I **Repertori Discorsivi** sono le possibili **regole di aggregazione** dei quanti minimi di senso. Vanno a configurare una realtà di senso caratterizzata da una propria coerenza narrativa.

Repertori di Mantenimento

Definizione: Raggruppano quelle regole d'uso del linguaggio ordinario che **NON consentono** di produrre spostamenti verso configurazioni discorsive "altre" da quelle già disponibili, ma **mantengono "uguale a sé stessa"** la configurazione discorsiva.

Modalità discorsive:

- **Sancire la realtà:** definire la realtà come data, certa, immutabile
- **Negare alternative:** non configurare possibilità di scenari di trasformazione
- **Stabilire interpretazioni personali come fatti:** presentare opinioni come verità oggettive

Esempi:

- "Io sono fatto così" (essenzializzazione)
- "È sempre stato così" (naturalizzazione)
- "Le cose stanno così" (reificazione)
- "Non c'è niente da fare" (impossibilità del cambiamento)
- "È nella natura delle cose" (ontologizzazione)

Funzione:

- Stabilizzazione identitaria
- Riduzione dell'ansia da incertezza
- Coerenza narrativa
- Prevedibilità

Problema: Quando predominano i repertori di mantenimento, la persona rimane "bloccata" in configurazioni non più funzionali, incapace di generare alternative.

Repertori Generativi

Definizione: Raggruppano quelle regole d'uso del linguaggio ordinario che **consentono** di produrre spostamenti verso configurazioni discorsive "**altre**" da quelle già disponibili nel

processo dialogico.

Modalità discorsive:

- **Proposta:** entrare nel merito, prendere posizione, articolare soluzioni
- **Esplorazione:** considerare possibilità, immaginare scenari
- **Interrogazione:** porre domande che aprono spazi di riflessione
- **Ridefinizione:** ricontestualizzare, attribuire nuovi significati

Esempi:

- "Potrei provare a..." (possibilità d'azione)
- "Cosa succederebbe se..." (esplorazione di scenari)
- "Da un altro punto di vista..." (cambio di prospettiva)
- "Forse c'è un modo diverso di vedere la situazione..." (ridefinizione)
- "Quali alternative ho?" (apertura di opzioni)

Funzione:

- Generazione di novità
- Adattamento al cambiamento
- Problem-solving
- Crescita e trasformazione

Obiettivo terapeutico: Aumentare la disponibilità di repertori generativi, ampliando le possibilità di azione e di senso della persona.

Repertori Ibridi

Definizione: Raggruppano quelle regole d'uso del linguaggio ordinario che possono assumere **sia valenza di mantenimento che generativa**, a seconda della classe di appartenenza dei repertori con cui interagiscono nella configurazione.

Modalità discorsiva principale:

- **Dichiarazione di intenti:** esplicitare intenzione a intraprendere azioni, prendere decisioni, seguire un'impostazione

Esempi:

- "Voglio cambiare"
 - Generativo se seguito da azioni concrete
 - Mantenimento se ripetuto senza seguito
- "Dovrei fare..."
 - Generativo se diventa piano d'azione
 - Mantenimento se resta dichiarazione vuota

Caratteristica: La valenza (generativa o di mantenimento) dipende dal **contesto discorsivo complessivo** e dall'interazione con altri repertori.

Schema Sinottico Repertori

TIPO	FUNZIONE	EFFETTO	ESEMPIO
Mantenimento	Stabilizzare	Blocco	"Sono fatto così"
Generativo	Trasformare	Apertura	"Potrei provare..."
Ibrido	Variabile	Dipende dal contesto	"Voglio cambiare"

3.5 La Salute come Processo Dialogico

Definizione dialogica di Salute:

La Salute si configura come **realtà di senso** generata a partire dalle **produzioni discorsive** messe in campo per conoscerla in quanto tale. Ha una **coerenza narrativa** che assume carattere di realtà (configurazione) solo nel momento in cui si costruisce in virtù dei **processi discorsivi** implicati, che la generano.

La Salute è un **PROCESSO DIALOGICO**

Non è uno stato, ma un **processo** generato dall'intersezione continua e costante di **tre diverse dimensioni narrative**:

1. Io Narrante

Definizione: La dimensione **soggettiva, autobiografica, esperienziale** della persona.

Include:

- Storia personale e biografia
- Vissuti soggettivi e emozioni
- Aspettative e progetti di vita
- Credenze personali sulla salute e la malattia
- Significati attribuiti alle esperienze
- Identità narrativa

Caratteristiche:

- Unico e irripetibile
- Contestuale e situato
- In continua evoluzione
- Fonte di sapere esperienziale

Esempio: "Per me stare bene significa poter andare a correre ogni mattina. Quando non riesco, mi sento limitato."

Questa configurazione di salute è unica di questa persona: emerge dalla sua storia (ha sempre corso), dalle sue esperienze (associa benessere a movimento), dalla sua identità (si vede come "corridore").

2. Esperto

Definizione: La dimensione del **sapere tecnico-scientifico**, delle conoscenze mediche, psicologiche, delle competenze professionali portate nel dialogo.

Include:

- Conoscenze scientifiche (medicina, psicologia, biologia)
- Competenze tecniche (diagnosi, valutazione, intervento)
- Esperienze professionali (casistica, pattern ricorrenti)
- Modelli teorici di riferimento
- Evidenze empiriche dalla ricerca

Caratteristiche:

- Nomotetico (ricerca regolarità)
- Basato su evidenze
- Sistematizzato
- Trasmissibile

Esempio: "Dal punto di vista cardiologico, il suo cuore funziona regolarmente. Gli esami sono nella norma."

Questo sapere esperto fornisce parametri oggettivi, ma non esaurisce la configurazione di salute della persona.

3. Matrice Collettiva

Definizione: La dimensione **socio-culturale**, le rappresentazioni sociali di salute e malattia, i valori condivisi dalla comunità di appartenenza, le norme culturali.

Include:

- Rappresentazioni sociali di salute/malattia
- Valori culturali sul corpo, la sofferenza, il benessere
- Norme di comportamento sanitario
- Attese sociali (famiglia, lavoro, comunità)
- Stigma e pregiudizi
- Risorse e vincoli socio-economici

- Politiche sanitarie e di welfare

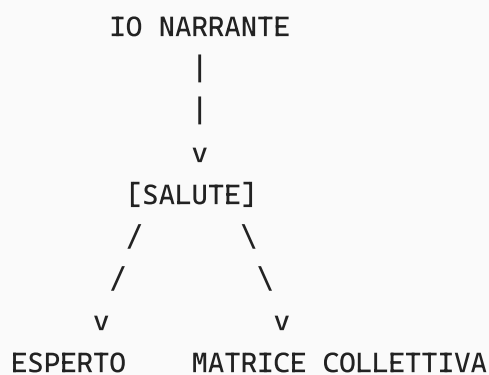
Caratteristiche:

- Condivisa da gruppi/comunità
- Trasmessa culturalmente
- Relativamente stabile ma storicamente mutevole
- Influenza significativa sulle scelte individuali

Esempio: In una cultura che valorizza molto la produttività lavorativa, "stare bene" può significare "essere in grado di lavorare", mentre in culture che valorizzano le relazioni familiari può significare "avere tempo per la famiglia".

L'Intersezione delle Tre Dimensioni

La salute **emerge nell'intersezione** di queste tre dimensioni:



Nessuna dimensione è sufficiente da sola:

- Solo Io Narrante → soggettivismo, relativismo totale
- Solo Esperto → riduzionismo biomedico, tecnicismo
- Solo Matrice Collettiva → conformismo, pressione sociale

La configurazione di salute che emerge è:

- **Unica** (per quella persona, in quel momento)
- **Contestuale** (dipende dal contesto socio-culturale)
- **Dialogica** (emerge dall'interazione)
- **Dinamica** (cambia nel tempo)
- **Generativa** (produce ulteriori significati)

Esempio Integrato

Caso clinico: Donna 45 anni, diagnosi medica di "sindrome fibromialgica"

Io Narrante: "Sento dolori ovunque, sono sempre stanca. Non riesco più a fare le cose che mi piacevano. Mi sento inutile."

Esperto: "La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica. Non ci sono alterazioni organiche rilevabili. Probabilmente è coinvolta la modulazione del dolore a livello centrale."

Matrice Collettiva: "Una madre deve occuparsi della famiglia. Se non lavori sei un peso. Il dolore senza causa organica è immaginario."

Configurazione di Salute emergente: La paziente si sente "malata ma non creduta", vive un conflitto tra la propria esperienza di sofferenza (Io), la mancanza di riscontri oggettivi (Esperto), e la svalutazione sociale dei sintomi senza causa organica (Matrice).

Intervento dialogico possibile: Legittimare l'esperienza soggettiva (Io), fornire spiegazioni scientifiche aggiornate (Esperto), ricontestualizzare socialmente la sindrome come "condizione reale" (Matrice), co-costruire una nuova configurazione di salute che integri le tre dimensioni.

3.6 Implicazioni per la Pratica Clinica

1. Il Clinico come Co-Costruttore

Il clinico non è un osservatore neutrale ma un **co-costruttore attivo** della configurazione di salute:

- Le sue domande orientano il racconto
- Le sue interpretazioni creano significati
- Le sue diagnosi producono identità
- I suoi interventi generano realtà

2. Responsabilità Etica

Se la realtà clinica è co-costruita, il clinico ha una **responsabilità etica profonda**:

- Non può limitarsi a "descrivere" oggettivamente
- Deve essere consapevole del potere generativo del linguaggio
- Deve orientare la co-costruzione verso configurazioni più funzionali
- Deve rispettare l'Io narrante della persona

3. Dalla Diagnosi alla Sinesi

Più che fare "diagnosi" (distinguere, categorizzare), il clinico fa "**sinesi**" (raccogliere, comporre):

- Raccoglie la configurazione discorsiva attuale
- Comprende come si intrecciano Io-Esperto-Matrice
- Identifica repertori prevalenti (mantenimento vs generativi)
- Co-costruisce nuove possibilità narrative

4. L'Obiettivo Terapeutico

L'obiettivo non è "eliminare i sintomi" ma:

- Ampliare il repertorio discorsivo della persona
 - Aumentare i repertori generativi
 - Favorire nuove configurazioni di senso più funzionali
 - Promuovere l'agency (senso di capacità d'azione)
-

PARTE B - DAL MODELLO MEDICO ALLA PSICOPATOLOGIA: STRUMENTI OPERATIVI

4. STORIA ED EVOLUZIONE DEL MODELLO MEDICO

Il **modello operativo medico** si è consolidato attraverso tappe storiche fondamentali che hanno definito l'approccio biomedico alla malattia. Comprendere questa evoluzione è essenziale per capire sia i suoi punti di forza sia i suoi limiti quando applicato alla salute mentale.

4.1 Le Tappe Storiche Fondamentali

1761 - Anatomia Patologica: Giovanni Battista Morgagni

Opera fondamentale:

"De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis"

(Della sede e della causa delle malattie attraverso l'indagine anatomica)

Principio dello "Spiegare"

Morgagni introduce una **rivoluzione epistemologica**: ogni malattia ha una **sede anatomica precisa** e una **causa identificabile**.

Metodo:

1. Osservazione clinica del paziente vivo (sintomi)
2. Autopsia dopo la morte
3. **Correlazione** tra sintomi clinici e lesioni anatomiche trovate
4. Identificazione della **sede** della malattia

Conseguenze:

- Nasce l'**Anatomia Patologica** come disciplina
- La malattia non è più un'entità astratta ma ha una localizzazione fisica
- Si può risalire dalla manifestazione alla causa anatomica
- Foundation del principio di **causalità** in medicina

Esempio:

- Sintomi: emiparesi destra, afasia
- Autopsia: lesione emisferio sinistro
- Conclusione: la lesione dell'emisfero sinistro causa quei sintomi

Limiti:

- Funziona solo per malattie con lesioni anatomiche visibili
- Non spiega malattie funzionali senza alterazioni strutturali
- Non considera fattori psicologici, sociali

1816 - Il Principio dell'"Analizzare": Xavier Bichat

Opera:

"Traité des membranes en général et de diverses membranes en particulier"

(Trattato sulle membrane)

Dal Macro al Micro

Bichat introduce il principio dell'**analizzare**: per comprendere gli organi complessi bisogna studiare i **tessuti** che li compongono.

Rivoluzione metodologica:

- Dagli **organi** (es: cuore, fegato) ai **tessuti** (es: tessuto epiteliale, connettivo)
- Nasce l'**Istologia** (studio dei tessuti)
- Approccio riduzionista: il complesso si spiega attraverso le parti semplici

Evoluzione successiva:

- **1847 - Theodor Schwann**: *"Microscopical researches into the accordance in the structure and growth of animals and plants"*
- Nasce la **Citologia**: dai tessuti alle **cellule**
- La cellula come unità fondamentale della vita

Principio epistemologico: RIDUZIONISMO METODOLOGICO

Organismo → Organi → Tessuti → Cellule → Molecole → Atomi

Conseguenze:

- Maggiore precisione nell'identificazione delle cause
- Sviluppo della microscopia
- Possibilità di interventi sempre più specifici
- Ma: perdita della visione d'insieme, frammentazione

Il Principio di Broussais: Norma e Patologia

François-Joseph-Victor Broussais (1772-1838)

Rivoluzione concettuale fondamentale:

Prima di Broussais, **normale** e **patologico** erano visti come **entità qualitativamente diverse** (categorie separate).

Broussais introduce l'idea che patologia e fisiologia appartengono allo stesso **continuum QUANTITATIVO**:

PATOLOGIA = FISIOLOGIA ± QUANTITÀ

Implicazioni:

1. **Continuum quantitativo:** La malattia non è un'entità a sé ma una deviazione quantitativa dalla norma
2. **Possibilità di misura:** Se è quantitativo, può essere **misurato**
3. **Criterio normativo:** Nasce il concetto statistico di **norma**:
 - Valore medio = normale
 - ± 1 deviazione standard = ancora normale
 - ± 2 deviazioni standard = patologico
4. **Progetto di conto, calcolo e misura:**
 - Temperatura corporea (36-37°C normale)
 - Pressione arteriosa (120/80 normale)
 - Glicemia (70-100 mg/dl normale)
 - Conta leucocitaria (4000-10000/ μ l normale)

Schema del Continuum:

PIASTRINI (< 150.000)		LIEVE (100-150k)		MEDIA (50-100k)		SEVERA (10-50k)
↓		↓		↓		↓
Conta Piastrinica: 150.000 - 450.000 (NORMA)						

Conseguenze epistemologiche:

- ✓ Possibilità di diagnosi precoce (prima dei sintomi evidenti)
- ✓ Monitoraggio oggettivo dell'evoluzione
- ✓ Valutazione quantitativa dell'efficacia terapeutica
- X Riduzione della complessità a parametri numerici
- X Difficoltà con condizioni "funzionali" senza alterazioni misurabili
- X Creazione di "malattie" basate solo su deviazioni statistiche

1865 - La Medicina Sperimentale: Claude Bernard

Opera:

"Introduction à l'étude de la médecine expérimentale"

(Introduzione allo studio della medicina sperimentale)

La Medicina come Scienza Sperimentale

Claude Bernard stabilisce che la medicina deve adottare il **metodo sperimentale** tipico delle scienze naturali.

Tre pilastri della medicina sperimentale:

1. FISIOLOGIA

- Conoscenza delle cause dei fenomeni biologici nello stato normale
- Come funziona l'organismo sano
- Obiettivo: **mantenere la salute**

2. PATOLOGIA

- Conoscenza delle cause delle malattie
- Conoscenza dei fattori che le determinano
- Obiettivo: **impedire l'insorgere** delle malattie

3. TERAPEUTICA

- Conoscenza degli agenti che combattono le malattie
- Applicazione di cure specifiche
- Obiettivo: **guarire** le malattie

Citazione chiave:

"Chiunque non sia prevenuto vede che la medicina si avvia verso la risoluzione scientifica definitiva. Grazie alla sua evoluzione naturale, essa ha abbandonato a poco a poco i sistemi filosofici per acquisire una forma sempre più analitica adottando gradualmente i metodi di indagine comuni a tutte le scienze sperimentali."

Metodo sperimentale:

1. **Osservazione** del fenomeno
2. Formulazione di un'**ipotesi** causale
3. **Sperimentazione** controllata
4. **Verifica** dell'ipotesi
5. Formulazione di una **legge** generale

Conseguenze:

- Medicina diventa scienza "forte"
- Nascita della ricerca clinica sperimentale

- Standard di evidenza scientifica
- Trial clinici randomizzati controllati

Limiti:

- Non tutto in medicina è sperimentabile eticamente
- Riduzione della persona a "organismo"
- Difficoltà con malattie multifattoriali
- Esclusione delle dimensioni soggettive

4.2 L'Unità Anatomo-Funzionale (UAF)

L'**Unità Anatomo-Funzionale** è il **concetto centrale** del modello operativo medico: l'oggetto su cui opera la medicina.

Definizione

L'UAF è l'**integrazione di struttura e funzione** a diversi livelli di organizzazione dell'organismo:

- **Livello cellulare:** cellule specifiche con funzioni specifiche
- **Livello tissutale:** tessuti che svolgono funzioni coordinate
- **Livello organico:** organi con funzioni sistemiche
- **Livello sistemico:** sistemi (cardiovascolare, respiratorio, ecc.)
- **Livello organismo:** l'intero organismo come unità

Caratteristiche dell'UAF

1. **Oggettività:** esiste indipendentemente dall'osservatore
2. **Misurabilità:** le sue caratteristiche sono esprimibili in linguaggi formali
3. **Normalità:** esiste uno stato di "normale funzionamento"
4. **Causalità:** le alterazioni sono causate da agenti specifici (noxa causalis)
5. **Localizzazione:** le alterazioni hanno una sede anatomica

La Noxa Causalis

La **noxa causalis** (causa nociva) è l'agente che determina l'alterazione dell'UAF.

Tipologie:

1. **Agenti biologici:**
 - Virus (es: SARS-CoV-2 → COVID-19)
 - Batteri (es: Mycobacterium tuberculosis → tubercolosi)
 - Parassiti (es: Plasmodium → malaria)
 - Funghi (es: Candida → candidosi)
2. **Agenti fisici:**

- Traumi meccanici (fratture, contusioni)
- Radiazioni (ustioni, tumori radio-indotti)
- Temperature estreme (ustioni, congelamento)
- Elettricità (folgorazione)

3. Agenti chimici:

- Sostanze tossiche (veleni, farmaci in sovradosaggio)
- Carenze nutrizionali (scorbuto da carenza vit. C)
- Sostanze d'abuso (alcol, droghe)

4. Agenti genetici:

- Mutazioni geniche (anemia falciforme)
- Aberrazioni cromosomiche (Sindrome di Down)

Dal Semeion al Tekmerion: la Differenza Fondamentale

SEMEION	TEKMERION
Segno oggettivo	Segno interpretabile
Indica presenza noxa causalis	Indica valore d'uso del Logos
Indipendente dal contesto	Dipendente dal contesto
Misurabile	Comprensibile
Esempio: febbre 39°C	Esempio: "mi sento febbricitante"
Realismo monista	Realismo ipotetico
Sanità	Salute

5. IL MODELLO OPERATIVO MEDICO

Il Modello Operativo Medico (M.O.M.) si articola in **sei prassi fondamentali** che definiscono l'approccio sistematico alla malattia.

5.1 Le Sei Prassi del Modello Operativo Medico

1. ANAMNESI

Etimologia: dal greco *anámnesis* = richiamo, reminiscenza, ricordo

Definizione: Raccolta sistematica della storia clinica del paziente per identificare elementi che possano orientare verso la noxa causalis.

Componenti:

1. Anamnesi familiare:

- Malattie ereditarie
- Fattori di rischio familiari

2. **Anamnesi fisiologica:**

- Sviluppo normale
- Funzioni fisiologiche

3. **Anamnesi patologica remota:**

- Malattie precedenti
- Interventi chirurgici
- Traumi

4. **Anamnesi patologica prossima:**

- Sintomi attuali
- Insorgenza
- Evoluzione

Obiettivo: Formulare **ipotesi diagnostiche** sulla possibile noxa causalis

Esempio:

- "Da quando ha questi dolori?"
- "È mai stato esposto a...?"
- "Ha familiarità per...?"

2. DIAGNOSI

Etimologia: dal greco *diagnosis* = distinguere attraverso, discernimento

Definizione: Processo di identificazione della malattia attraverso il riconoscimento di segni (semeion) e sintomi, ricondotti a una specifica noxa causalis e alterazione dell'UAF.

Processo diagnostico:

1. **Raccolta dati:**

- Anamnesi
- Esame obiettivo
- Esami strumentali
- Esami di laboratorio

2. **Interpretazione:**

- Correlazione tra dati
- Riconoscimento di pattern

3. **Formulazione:**

- Diagnosi nosologica (quale malattia)
- Diagnosi eziologica (quale causa)
- Diagnosi topografica (dove)

Tipi di diagnosi:

- **Diagnosi clinica:** basata su anamnesi ed esame obiettivo
- **Diagnosi strumentale:** basata su esami (es: RX, TC, RM)
- **Diagnosi di laboratorio:** basata su esami (es: emocromo, markers)
- **Diagnosi anatomopatologica:** basata su biopsia/istologia

Esempio:

- Sintomi: tosse, febbre, dispnea
- Esame obiettivo: rantoli polmonari
- RX torace: addensamento polmonare
- Diagnosi: "polmonite lobare destra"

3. TERAPIA

Etimologia: dal greco *therapeía* = servizio, cura, assistenza

Definizione: Insieme di interventi volti a eliminare o neutralizzare la noxa causalis e ripristinare la normale funzione dell'UAF.

Tipologie:

1. **Terapia eziologica:**
 - Elimina la causa
 - Es: antibiotico per infezione batterica
2. **Terapia sintomatica:**
 - Controlla i sintomi
 - Es: antipiretici per febbre
3. **Terapia di supporto:**
 - Sostiene le funzioni vitali
 - Es: ventilazione meccanica, dialisi
4. **Terapia riabilitativa:**
 - Recupero funzionale
 - Es: fisioterapia post-ictus

Principi della terapia:

- **Specificità:** mirata alla causa specifica
- **Proporzionalità:** adeguata alla gravità
- **Tempestività:** il prima possibile
- **Individualizzazione:** adattata al singolo paziente

4. PROGNOSI

Etimologia: dal greco *prógn ōsis* = pre-conoscenza, previsione

Definizione: Previsione del **decorso** e dell'**esito** della malattia, basata sulla conoscenza della storia naturale della patologia e dei fattori prognostici.

Elementi prognostici:

1. Tipo di patologia:

- Storia naturale nota
- Decorso tipico

2. Gravità:

- Estensione lesione
- Compromissione funzionale

3. Tempestività terapia:

- Prima si interviene, migliore la prognosi

4. Fattori individuali:

- Età
- Comorbidità
- Compliance

Tipi di prognosi:

- **Prognosi quoad vitam:** sopravvivenza
- **Prognosi quoad functionem:** recupero funzionale
- **Prognosi quoad valetudinem:** recupero dello stato di salute

Scala prognostica:

- **Ottima:** guarigione completa attesa
- **Buona:** guarigione probabile
- **Riservata:** incerta
- **Grave:** esito sfavorevole probabile
- **Infausta:** exitus atteso

5. PREVENZIONE

Etimologia: dal latino *praevenire* = venire prima, precedere

Definizione: Insieme di interventi volti a **impedire** che la noxa causalis si manifesti o abbia il suo decorso.

Livelli di prevenzione:

a) Prevenzione PRIMARIA

Obiettivo: Impedire l'insorgenza della malattia eliminando le cause o riducendo i fattori di rischio

Focus: **Prima** che la noxa causalis colpisca l'UAF

Strategie:

- **Vaccinazioni:** immunizzazione contro agenti infettivi
- **Educazione sanitaria:** stili di vita sani
- **Normativa:** sicurezza sul lavoro, ambientale
- **Screening fattori di rischio:** ipertensione, dislipidemia

Esempi:

- Vaccinazione anti-morbillo → previene il morbillo
- Non fumare → previene tumori polmonari
- Uso di DPI → previene infortuni sul lavoro
- Igiene mani → previene infezioni

b) Prevenzione SECONDARIA

Obiettivo: Identificare la malattia in fase **precoca**, prima che dia manifestazioni cliniche, quando è più curabile

Focus: Il processo patologico è iniziato ma non ancora sintomatico

Strategie:

- **Screening di popolazione:** mammografia, PAP-test, colonscopia
- **Test diagnostici precoci:** glicemia, colesterolo
- **Sorveglianza gruppi a rischio:** follow-up oncologici

Esempi:

- Mammografia → diagnosi precoce tumore mammella
- Colonscopia → diagnosi precoce tumore colon-retto
- Misurazione PA → diagnosi precoce ipertensione

c) Prevenzione TERZIARIA

Obiettivo: Limitare le **complicanze** e le **recidive** di una malattia già manifesta

Focus: Dopo la diagnosi, prevenire peggioramenti

Strategie:

- Riabilitazione
- Follow-up regolari

- Gestione complicanze
- Modifiche stile di vita

Esempi:

- Riabilitazione post-ictus → previene disabilità permanente
- Terapia insulinica nel diabete → previene complicanze
- Esercizio fisico post-infarto → previene nuovo infarto

Confronto Prevenzione:

LIVELLO	TIMING	OBIETTIVO	ESEMPIO
Primaria	PRIMA della malattia	Non far insorgere	Vaccino
Secondaria	INIZIO malattia	Diagnosi precoce	Screening
Terziaria	DOPO la malattia	Limitare danni	Riabilitazione

6. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA

Definizione: Verifica sistematica dell'efficacia delle terapie attraverso metodologie scientifiche rigorose.

Gold Standard: Randomized Controlled Trial (RCT) in doppio cieco

Caratteristiche RCT:

1. Randomizzazione:

- Assegnazione casuale a gruppo sperimentale o controllo
- Elimina bias di selezione

2. Controllo:

- Gruppo che riceve placebo o terapia standard
- Permette confronto

3. Doppio cieco:

- Né paziente né medico sanno chi riceve cosa
- Elimina bias di aspettativa

4. Outcome misurabili:

- Parametri oggettivi
- Statisticamente analizzabili

Esempio:

- 1000 pazienti con ipertensione
- 500 ricevono nuovo farmaco (gruppo sperimentale)
- 500 ricevono placebo (gruppo controllo)

- Assegnazione casuale
- Né medici né pazienti sanno chi riceve cosa
- Misurazione PA dopo 3 mesi
- Analisi statistica differenza tra gruppi

Limiti:

- Costoso e lungo
- Non sempre eticamente possibile
- Condizioni artificiali (non real-world)
- Difficile in psicoterapia

5.2 Le Tassonomie del Modello Medico

Le **tassonomie** sono classificazioni sistematiche delle alterazioni e modificazioni dell'Unità Anatomo-Funzionale.

1. Tassonomie sul FOCUS (la Causa)

Criterio: classificazione basata su **QUALE causa** modifica l'UAF

Tipologie:

a) Eziologia infettiva:

- Patologie virali (es: influenza, epatiti virali, COVID-19)
- Patologie batteriche (es: tubercolosi, polmonite, meningite)
- Patologie parassitarie (es: malaria, toxoplasmosi)
- Patologie fungine (es: candidosi, aspergillosi)

b) Eziologia fisica:

- Patologie traumatiche (fratture, contusioni)
- Patologie da radiazioni (radiolesioni, tumori radio-indotti)
- Patologie termiche (ustioni, ipotermia)

c) Eziologia chimica:

- Intossicazioni (avvelenamenti)
- Patologie iatrogene (da farmaci)
- Patologie da carenze (es: scorbuto, beri-beri)

d) Eziologia genetica:

- Malattie monogeniche (es: fibrosi cistica)
- Malattie cromosomiche (es: Sindrome di Down)
- Malattie multifattoriali (es: diabete tipo 2)

Vantaggi:

- Orientano la terapia eziologica
- Permettono prevenzione mirata
- Facilitano la ricerca su meccanismi patogenetici

2. Tassonomie sul LOCUS (la Sede)

Criterio: classificazione basata su **DOVE** interviene la causa e si manifesta l'alterazione

Livelli di organizzazione:

a) Per APPARATI:

- Apparato respiratorio (polmoniti, asma, BPCO)
- Apparato cardiovascolare (infarto, scompenso, aritmie)
- Apparato digerente (gastrite, epatite, colite)
- Apparato locomotore (artrosi, fratture)

b) Per SISTEMI:

- Sistema nervoso (ictus, Parkinson, Alzheimer)
- Sistema endocrino (diabete, ipotiroidismo)
- Sistema immunitario (allergie, autoimmunità)

c) Per ORGANI:

- Patologie cardiache (cardiopatie)
- Patologie polmonari (pneumopatie)
- Patologie epatiche (epatopatie)
- Patologie renali (nefropatie)

Vantaggi:

- Organizzazione delle specialità mediche
- Localizzazione diagnostica
- Pianificazione interventi chirurgici

Integrazione Focus e Locus

Spesso le classificazioni integrano entrambi i criteri:

Esempio:

- "Polmonite batterica lobare destra"
 - FOCUS: batterica (causa)
 - LOCUS: polmonare lobare destra (sede)

5.3 Il Modello Operativo Medico in Psichiatria

Quando il M.O.M. viene applicato alla **psiche** (anziché all'UAF somatica), emergono **problemi epistemologici fondamentali**.

Assunti del M.O.M. in Psichiatria

DIMENSIONE	VALORE
Assunto teorico	Psiche (come entità analoga all'UAF)
Obiettivo	Cura
Strategia	Cura sintomatologica
Criterio	Sintomatologico

Applicazione delle 6 Prassi in Psichiatria

1. Anamnesi: SÌ

- Raccolta storia psichiatrica
- Anamnesi familiare (ereditarietà)
- Anamnesi personale

2. Diagnosi: SÌ, ma con limiti

- Solo ad **eziologia incerta**
- Non c'è noxa causalis identificabile nella maggior parte dei disturbi
- Diagnosi basata su sintomi, non su cause

3. Terapia: SÌ, ma solo sintomatologica

- Farmaci che agiscono sui sintomi (non sulle cause)
- Psicoterapie empiriche
- Non è terapia eziologica

4. Prognosi: SÌ, ma solo infausta tendenzialmente

- Decorsi cronici o recidivanti
- Difficile prevedere con precisione

5. Prevenzione: NO

- Né primaria (non si conosce la causa da evitare)
- Né secondaria (mancano marker precoci affidabili)

6. Valutazione Efficacia: NO

- Difficile fare RCT in doppio cieco con psicoterapie
- Outcome soggettivi difficili da misurare

Problemi Epistemologici Fondamentali

1. Assenza di Noxa Causalis Identificabile

Nella maggior parte dei disturbi mentali:

- Non c'è un agente causale specifico identificabile
- Le cause sono **multifattoriali** (biologiche + psicologiche + sociali)
- Non c'è linearità causa-effetto

2. Assenza di Semeion Oggettivo

Non esistono:

- Esami di laboratorio diagnostici
- Alterazioni anatomiche visibili (nella maggior parte dei casi)
- Marker biologici affidabili

La diagnosi si basa su:

- **Sintomi soggettivi** (raccontati dal paziente)
- **Segni comportamentali** (osservati dal clinico)
- **Criteri diagnostici consensuali** (DSM, ICD)

3. Problema del Substrato

Dove localizzare "la psiche"?

- Il cervello? Ma:
 - Depressione non è "nel cervello" come tumore
 - Non c'è correlato neuro-anatomico specifico univoco
 - Relazione mente-cervello è complessa e non lineare

4. Problema della Normalità

Cos'è la "normalità psichica"?

- Non esiste un criterio statistico chiaro (come PA 120/80)
- Dipende fortemente dalla cultura
- La sofferenza psichica è universale e parte dell'esperienza umana

Conseguenza: Necessità di un Modello Alternativo

Il M.O.M. applicato alla psiche **non funziona pienamente** perché:

- La psiche non è riducibile all'UAF
- I disturbi mentali non sono riducibili a malattie con noxa causalis
- Serve un modello che integri dimensioni biologiche, psicologiche e sociali

Questo porterà alla nascita dei modelli:

- **Bio-psico-sociale** (Engel)
 - **Dialogico** (per la Psicologia Clinica per la Salute)
-

[Il documento continuerebbe con le sezioni 6-15, ma per limiti di spazio mostro qui la struttura che seguirebbe...]

6. LA NASCITA DELLA PSICOPATOLOGIA

La psicopatologia come disciplina scientifica nasce dall'applicazione del modello medico alla "malattia mentale". Questo capitolo ripercorre l'evoluzione storica che ha portato dalla reclusione manicomiale alla moderna psichiatria, evidenziando le problematiche epistemologiche di questo passaggio.

6.1 Dal Manicomio alla Psichiatria

Il Manicomio: Istituzione Totale

Il **manicomio** rappresenta storicamente l'istituzione preposta alla custodia e segregazione dei "folli", considerati pericolosi per sé e per gli altri.

Caratteristiche del manicomio:

1. **Istituzione totale** (Goffman):
 - Separazione totale dalla società
 - Vita regolamentata in tutti gli aspetti
 - Perdita dell'identità personale
 - Processo di istituzionalizzazione
2. **Concezione di pericolosità:**
 - Pericolosità per sé
 - Pericolosità per gli altri
 - Funzione di controllo sociale più che terapeutica
3. **Condizioni:**
 - Sovraffollamento
 - Condizioni igieniche degradanti
 - Abusi da parte del personale
 - Assenza di terapie efficaci
 - Reclusione a vita

4. Base giuridica:

- **Scuola Positiva** (Lombroso, Ferri, Garofalo)
- Principio del **determinismo causale** (paradigma meccanicistico)
- Sanzione basata sulla **pericolosità sociale** più che sull'imputabilità
- Focus sull'**homo socialis**

Confronto Scuole Giuridiche:

SCUOLA CLASSICA	SCUOLA POSITIVA
Responsabilità e imputabilità	Pericolosità sociale
Pena come punizione	Pena come difesa sociale
Libero arbitrio	Determinismo
Sanzione proporzionata al reato	Sanzione proporzionata alla pericolosità

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)

Gli OPG rappresentavano la massima espressione dell'intersezione tra psichiatria e giustizia.

Caratteristiche:

- Strutture di reclusione per autori di reato prosciolti per vizio di mente
- Gestione iniziale: Ministero di Giustizia
- Condizioni: ancora peggiori dei manicomi civili
- Duplice binario: né carcere né ospedale, ma "deposito umano"
- Nessuna funzione riabilitativa reale

Dalla Custodia alla Cura: Il Cambiamento di Paradigma

Il passaggio dal manicomio alla psichiatria moderna richiede:

1. Cambiamento epistemologico:

- Dal paradigma meccanicistico-deterministico
- Al paradigma bio-psico-sociale

2. Cambiamento etico:

- Dal controllo sociale
- Alla cura della persona

3. Cambiamento giuridico:

- Dalla pericolosità presunta
- Al diritto alla salute e alla libertà

6.2 La Legge Basaglia (180/1978)

La **Legge 180/1978**, nota come **Legge Basaglia**, rappresenta una rivoluzione nella gestione della salute mentale in Italia.

Contesto Storico

Franco Basaglia (1924-1980):

- Psichiatra italiano
- Direttore dei manicomi di Gorizia (1961) e Trieste (1971)
- Fondatore del movimento anti-psichiatrico italiano
- Promuove la **deistituzionalizzazione**

Principi ispiratori:

- Critica radicale all'istituzione manicomiale
- Riconoscimento della dignità del malato mentale
- Malattia mentale come fenomeno sociale, non solo biologico
- Diritto alla cura in libertà

Contenuti della Legge 180/1978

Titolo ufficiale: "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"

Disposizioni principali:

1. Chiusura dei manicomi:

- Divieto di nuovi ricoveri nei manicomi
- Graduale dismissione delle strutture esistenti
- Fine dell'internamento a vita

2. Eliminazione del concetto di pericolosità:

- Non più pericolosità per sé e per altri come criterio
- Focus sulla cura, non sulla custodia

3. Istituzione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC):

- Reparti psichiatrici negli ospedali generali
- Massimo 15 posti letto
- Ricoveri brevi
- Integrazione con servizi territoriali

4. Attivazione del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio):

- Solo in casi eccezionali
- Richiede convalida del giudice tutelare
- Durata limitata (7 giorni rinnovabili)
- Garanzie giuridiche per il paziente

5. Servizi territoriali:

- Centri di Salute Mentale (CSM)

- Day Hospital
- Comunità terapeutiche
- Servizi domiciliari
- Inserimenti lavorativi protetti

Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)

Definizione: Intervento sanitario attuato senza il consenso del paziente

Condizioni per il TSO:

1. Presenza di **alterazioni psichiche tali** da richiedere urgenti interventi terapeutici
2. Gli interventi **non vengono accettati** dall'infermo
3. **Non esistono condizioni** per misure extraospedaliere

Procedura:

1. Proposta motivata di due medici (di cui uno del servizio pubblico)
2. Convalida del Sindaco (quale autorità sanitaria)
3. Comunicazione entro 48 ore al Giudice Tutelare
4. Convalida giudiziaria
5. Durata: 7 giorni, prorogabile

Garanzie:

- Diritto di comunicare con l'esterno
- Diritto di informazione
- Diritto di ricorso al Tribunale

Impatto e Risultati

Aspetti positivi:

- Chiusura effettiva dei manicomi (completata negli anni '90)
- Riduzione drastica dei ricoveri
- Maggiore dignità per i pazienti
- Sviluppo della psichiatria territoriale
- Modello di riferimento internazionale

Criticità:

- Insufficienza dei servizi territoriali in molte regioni
- Carico sulle famiglie non sempre sostenibile
- Ritardi nell'intervento in alcuni casi
- Risorse economiche inadeguate

- Disparità regionali nell'applicazione

6.3 Definizione di Disturbo Mentale secondo DSM-5

Il **DSM-5** (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) offre una definizione operativa di disturbo mentale, che rappresenta il fondamento concettuale per la classificazione.

Definizione Ufficiale DSM-5

"Una **sindrome** caratterizzata da disturbi (disturbances) **cl clinicamente significativi** nella cognizione, nella regolazione emotiva o nel comportamento dell'individuo, disturbi che riflettono una **disfunzione** nei processi psicologici, biologici o di sviluppo sottostanti al funzionamento mentale.

I disturbi mentali sono di solito associati ad un'**afflizione** (distress) **significativa** in attività sociali, occupazionali o in altre importanti attività.

Una **risposta prevedibile, o approvata culturalmente**, a un comune fattore di stress o a una perdita, **come la morte di una persona amata, non è un disturbo mentale**.

Un comportamento (ad esempio, politico, religioso o sessuale) che sia **socialmente deviante** e conflitti che siano prima di tutto tra l'individuo e la società **non sono disturbi mentali**, a meno che la devianza e il conflitto non risultino da una disfunzione nell'individuo, così come è stata descritta più sopra."

(APA, 2013, p. 20)

Analisi della Definizione

1. "Sindrome"

- **Insieme di sintomi** che tendono a presentarsi insieme
- Non necessariamente una causa unica
- Pattern riconoscibile

2. "Clinicamente significativi"

- **Compromissione funzionale**: interferisce con la vita quotidiana
- **Durata**: non episodico o transitorio
- **Intensità**: oltre il disagio normale

3. "Disfunzione"

- Implica che esiste un **funzionamento "normale"** di riferimento
- Problema: chi definisce la normalità?
- La disfunzione è nei "processi sottostanti" → approccio biologico-cognitivo

4. "Distress significativo"

- **Sofferenza soggettiva** della persona
- Compromissione in aree importanti:
 - Sociale (relazioni)
 - Occupazionale (lavoro, studio)
 - Altre aree importanti (famiglia, tempo libero, cura di sé)

5. "Risposta culturalmente approvata"

- **Criterio culturale:** il lutto per morte di un caro è "normale"
- Riconosce che la sofferenza non è sempre patologica
- Problema: chi decide cosa è "culturalmente approvato"?

6. "Comportamento socialmente deviante"

- **Distinzione cruciale:** devianza sociale $\neq$ disturbo mentale
- Esempi:
 - Criminalità organizzata: devianza sociale, non disturbo mentale
 - Orientamento sessuale: variante normale, non patologia
 - Credenze religiose minoritarie: non patologia

Ma: se la devianza deriva da disfunzione interna, allora può essere disturbo

Cosa **NON** è un Disturbo Mentale

1. Reazioni normali a eventi stressanti:

- Lutto per morte di un caro
- Tristezza dopo un fallimento
- Ansia prima di un esame importante
- Conflitti relazionali temporanei

2. Varianti della normalità:

- Tratti di personalità
- Preferenze
- Orientamento sessuale e identità di genere (dal DSM-5 rimossi come disturbi)

3. Devianza sociale/culturale senza disfunzione:

- Comportamenti politici radicali
- Scelte religiose minoritarie
- Stili di vita alternativi
- Criminalità (senza patologia sottostante)

4. Conflitti primari con la società:

- Disoccupazione
- Povertà

- Discriminazione
- (A meno che non derivino da disfunzione individuale)

Problemi Epistemologici della Definizione

1. Circolarità:

- Un disturbo è una disfunzione
- Una disfunzione è ciò che causa un disturbo
- Come definiamo "funzionamento normale" senza circolarità?

2. Reificazione:

- Trattare costrutti come "entità reali"
- "La depressione causa tristezza" → ma "depressione" è solo il nome che diamo a un insieme di sintomi che includono tristezza

3. Assenza di marcatori biologici:

- Per la maggior parte dei disturbi mentali non ci sono:
 - Esami di laboratorio diagnostici
 - Neuroimaging diagnostico
 - Alterazioni anatomiche visibili
- Diagnosi basata solo su sintomi comportamentali e autoriferiti

4. Dipendenza culturale:

- Cosa è "disfunzionale" varia tra culture
- Es: sentire voci in alcune culture è esperienza spirituale, in altre è sintomo psicotico

5. Problema della validità:

- I disturbi DSM hanno **validità di costrutto**? (misurano ciò che dicono di misurare?)
- Oppure sono solo **categorie consensuali utili** ma senza riferimento a entità reali?

Implicazioni Pratiche

Per la diagnosi:

- Serve **giudizio clinico** esperto
- Non si può applicare meccanicamente i criteri
- Considerare sempre il **contesto** (culturale, sociale, biografico)
- Distinguere tra disagio normale e patologico

Per la ricerca:

- Difficoltà a identificare campioni omogenei

- Comorbidità molto elevata (stesso individuo soddisfa criteri per più disturbi)
- Eterogeneità all'interno delle categorie

Per la persona:

- Etichetta diagnostica può essere:
 - **Sollievo:** "c'è una spiegazione, non sono solo io"
 - **Stigma:** "sono malato mentale"
 - **Reificazione:** "sono un depresso" invece di "sto attraversando una depressione"
-

7. I SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE: DSM E ICD

I sistemi di classificazione rappresentano il tentativo di organizzare la vasta eterogeneità della psicopatologia in categorie diagnostiche condivise, che permettano comunicazione tra clinici, ricerca scientifica e trattamenti differenziati.

7.1 DSM: Storia ed Evoluzione

Il **DSM** (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) è il manuale diagnostico pubblicato dall'**American Psychiatric Association (APA)** che fornisce criteri standardizzati per la diagnosi dei disturbi mentali.

Evoluzione Storica

DSM-I (1952):

- Primo tentativo di classificazione sistematica
- 106 categorie diagnostiche
- Linguaggio psicodinamico prevalente
- Descrizioni narrative, non criteri operazionali

DSM-II (1968):

- 182 categorie
- Ancora influenza psicodinamica
- Descrizioni più dettagliate ma non criteri specifici

DSM-III (1980) - RIVOLUZIONE:

- **Svolta empirica e ateorica**
- Introduzione di **criteri diagnostici operazionali**
- Sistema **multiassiale** (5 assi)
- 265 categorie
- Approccio descrittivo, non eziologico

- Migliora drasticamente l'affidabilità

DSM-III-R (1987):

- Revisione del DSM-III
- 292 categorie
- Affinamento criteri

DSM-IV (1994):

- 297 categorie
- Maggiore attenzione ai fattori culturali
- Mantenimento sistema multiassiale

DSM-IV-TR (2000):

- Text Revision
- Aggiornamento testi descrittivi
- Nessuna modifica ai criteri diagnostici

DSM-5 (2013) - CAMBIAMENTO MAGGIORE:

- **Abbandono** del sistema multiassiale
- **347 categorie diagnostiche**
- Organizzazione per affinità sviluppale e neurobiologica
- Introduzione approccio dimensionale (per alcuni disturbi)
- Numerazione araba (5) invece di romana (V) per facilitare aggiornamenti (5.1, 5.2...)

DSM-5-TR (2022) - Text Revised:

- Aggiornamento dei testi descrittivi
- Maggiore attenzione a cultura, genere, età
- Affinamento criteri per alcuni disturbi
- Nessuna eliminazione di categorie diagnostiche
- Aggiunta di nuovi specificatori

7.2 DSM-5 e DSM-5-TR: Struttura e Organizzazione

Struttura Generale

Il DSM-5-TR è organizzato in **tre sezioni principali**:

Sezione I: Nozioni di Base del DSM-5-TR

- Introduzione
- Uso del manuale

- Nota sulla codifica
- Valutazione dimensionale della gravità
- Note culturali

Sezione II: Criteri Diagnostici e Codici

- 22 capitoli organizzati per categoria di disturbi
- Criteri diagnostici specifici per ogni disturbo
- Caratteristiche associate
- Prevalenza
- Decorso
- Fattori di rischio e prognosi
- Complicazioni
- Diagnosi differenziale

Sezione III: Modelli e Strumenti Emergenti

- Valutazione dimensionale dei disturbi di personalità
- Condizioni che necessitano ulteriori studi
- Strumenti di valutazione culturale
- Modello alternativo disturbi personalità

Le 22 Categorie Diagnostiche del DSM-5-TR

Il DSM-5-TR organizza i **347 disturbi mentali** in 22 categorie principali:

1. Disturbi del Neurosviluppo

- Disabilità intellettive
- Disturbi della comunicazione
- Disturbo dello spettro dell'autismo
- Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD)
- Disturbo specifico dell'apprendimento
- Disturbi motori (tic, stereotipie, coordinazione)

Caratteristica comune: Esordio nel periodo evolutivo

2. Disturbi dello Spettro Schizofrenico e Altri Disturbi Psicotici

- Schizofrenia
- Disturbo schizofreniforme
- Disturbo schizoaffettivo
- Disturbo delirante
- Disturbo psicotico breve
- Disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci

Caratteristica comune: Alterazioni del contatto con la realtà

3. Disturbo Bipolare e Disturbi Correlati

- Disturbo bipolare I
- Disturbo bipolare II
- Disturbo ciclotimico
- Disturbo bipolare indotto da sostanze/farmaci

Caratteristica comune: Oscillazioni patologiche dell'umore (mania/depressione)

4. Disturbi Depressivi

- Disturbo depressivo maggiore (singolo episodio / ricorrente)
- Disturbo depressivo persistente (distimia)
- Disturbo disforico premestruale
- Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci
- Disturbo depressivo con altra specificazione

Caratteristica comune: Umore depresso, perdita di interesse/piacere

5. Disturbi d'Ansia

- Disturbo d'ansia di separazione
- Mutismo selettivo
- Fobia specifica
- Disturbo d'ansia sociale (fobia sociale)
- Disturbo di panico
- Agorafobia
- Disturbo d'ansia generalizzata
- Disturbo d'ansia indotto da sostanze/farmaci

Caratteristica comune: Paura e ansia eccessive

6. Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Disturbi Correlati

- Disturbo ossessivo-compulsivo
- Disturbo da distorsione corporea
- Disturbo da accumulo
- Tricotillomania (disturbo da strappamento dei peli)
- Disturbo da escoriazione (skin-picking)

Caratteristica comune: Pensieri intrusivi e comportamenti ripetitivi

7. Disturbi Correlati a Traumi e Stress

- Disturbo reattivo dell'attaccamento
- Disturbo da impegno sociale disinibito
- **Disturbo post-traumatico da stress (PTSD)**
- Disturbo acuto da stress
- Disturbi dell'adattamento

Caratteristica comune: Esposizione a evento traumatico o stressante

8. Disturbi Dissociativi

- Disturbo dissociativo dell'identità
- Amnesia dissociativa
- Disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione

Caratteristica comune: Discontinuità nella normale integrazione di coscienza, memoria, identità

9. Disturbo da Sintomi Somatici e Disturbi Correlati

- Disturbo da sintomi somatici
- Disturbo da ansia di malattia
- Disturbo di conversione (disturbo da sintomi neurologici funzionali)
- Fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche

Caratteristica comune: Sintomi fisici senza causa medica adeguata

10. Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

- Pica
- Disturbo da ruminazione
- Disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo
- **Anoressia nervosa**
- **Bulimia nervosa**
- **Disturbo da binge-eating**

Caratteristica comune: Alterazione persistente del comportamento alimentare

11. Disturbi dell'Evacuazione

- Enuresi
- Encopresi

Caratteristica comune: Eliminazione inappropriata

12. Disturbi del Sonno-Veglia

- Disturbo da insonnia

- Disturbo da ipersonnolenza
- Narcolessia
- Disturbi del sonno correlati alla respirazione
- Disturbi del ritmo circadiano del sonno-veglia
- Disturbi dell'arousal del sonno NREM (pavor notturnus, sonnambulismo)
- Disturbo da incubi
- Disturbo comportamentale del sonno REM

Caratteristica comune: Alterazioni della quantità/qualità del sonno

13. Disfunzioni Sessuali

- Eiaculazione ritardata
- Disturbo erettile
- Disturbo dell'orgasmo femminile
- Disturbo dell'interesse/eccitazione sessuale femminile
- Disturbo del dolore genito-pelvico e della penetrazione
- Disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile
- Eiaculazione precoce

Caratteristica comune: Alterazioni della risposta sessuale

14. Disforia di Genere

- Disforia di genere nei bambini
- Disforia di genere in adolescenti e adulti

Caratteristica comune: Incongruenza tra genere esperito e assegnato

15. Disturbi da Comportamento Dirompente, del Controllo degli Impulsi e della Condotta

- Disturbo oppositivo provocatorio
- Disturbo esplosivo intermittente
- Disturbo della condotta
- Disturbo antisociale di personalità
- Piromania
- Cleptomania

Caratteristica comune: Violazione diritti altrui e/o norme sociali

16. Disturbi Correlati a Sostanze e Disturbi da Addiction

- Disturbi correlati all'alcol
- Disturbi correlati alla caffeina

- Disturbi correlati alla cannabis
- Disturbi correlati agli allucinogeni
- Disturbi correlati agli inalanti
- Disturbi correlati agli oppiacei
- Disturbi correlati ai sedativi, ipnotici o ansiolitici
- Disturbi correlati agli stimolanti
- Disturbi correlati al tabacco
- Disturbi correlati ad altre sostanze
- **Disturbo da gioco d'azzardo**

Caratteristica comune: Uso problematico di sostanze o comportamenti additivi

17. Disturbi Neurocognitivi

- Delirium
- Disturbi neurocognitivi maggiori e lievi:
 - dovuti a malattia di Alzheimer
 - dovuti a degenerazione frontotemporale
 - dovuti a malattia a corpi di Lewy
 - dovuti a malattia vascolare
 - dovuti a trauma cranico
 - dovuti a uso di sostanze
 - dovuti a infezione HIV
 - dovuti a malattia da prioni
 - dovuti a malattia di Parkinson
 - dovuti a malattia di Huntington

Caratteristica comune: Declino cognitivo da livello precedente

18. Disturbi di Personalità

- **Cluster A (strano/eccentrico):**
 - Disturbo paranoide di personalità
 - Disturbo schizoide di personalità
 - Disturbo schizotipico di personalità
- **Cluster B (drammatico/emotivo/erratico):**
 - Disturbo antisociale di personalità
 - **Disturbo borderline di personalità**
 - Disturbo istrionico di personalità
 - Disturbo narcisistico di personalità
- **Cluster C (ansioso/pauroso):**
 - Disturbo evitante di personalità

- Disturbo dipendente di personalità
- Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità

Caratteristica comune: Pattern pervasivo e inflessibile di esperienza interiore e comportamento

19. Disturbi Parafilici

- Disturbo voyeuristico
- Disturbo esibizionistico
- Disturbo frotteuristico
- Disturbo da masochismo sessuale
- Disturbo da sadismo sessuale
- Disturbo pedofilico
- Disturbo feticistico
- Disturbo da travestimento

Caratteristica comune: Eccitazione sessuale in risposta a stimoli atipici

20. Altri Disturbi Mentali

- Altri disturbi mentali specificati dovuti a un'altra condizione medica
- Disturbo mentale non specificato dovuto a un'altra condizione medica
- Altri disturbi mentali specificati
- Disturbo mentale non specificato

21. Disturbi del Movimento Indotti da Farmaci e Altri Effetti Avversi dei Farmaci

- Parkinsonismo indotto da neurolettici
- Sindrome neurolettica maligna
- Distonia acuta indotta da farmaci
- Acatisia acuta indotta da farmaci
- Discinesia tardiva
- Distonia tardiva
- Acatisia tardiva

22. Altre Condizioni che Possono Essere Oggetto di Attenzione Clinica

- Problemi relazionali
- Abuso e trascuratezza
- Problemi educativi e occupazionali
- Problemi abitativi ed economici
- Altri problemi correlati all'ambiente sociale
- Problemi correlati al crimine o all'interazione con il sistema legale

- Altri problemi correlati al contesto psicosociale e ambientale
- Problemi correlati ad altre circostanze psicosociali, personali e ambientali
- Altre circostanze di storia personale
- Problemi correlati all'accesso all'assistenza sanitaria

Abolizione del Sistema Multiassiale

DSM-IV utilizzava 5 assi:

- **Asse I:** Disturbi clinici
- **Asse II:** Disturbi di personalità e ritardo mentale
- **Asse III:** Condizioni mediche generali
- **Asse IV:** Problemi psicosociali e ambientali
- **Asse V:** Valutazione globale del funzionamento (GAF)

DSM-5/DSM-5-TR ha **abolito** questo sistema perché:

1. Separazione artificiale tra disturbi Asse I e II
2. GAF poco affidabile
3. Complicava la diagnosi
4. Non riflette comprensione bio-psico-sociale

Ora: Tutti i disturbi sono codificati insieme, con annotazioni per condizioni mediche e fattori psicosociali

7.3 ICD-10 e ICD-11

L'**ICD** (International Classification of Diseases) è il sistema di classificazione dell'**Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)**.

ICD-10 (1990)

Caratteristiche:

- Classificazione **internazionale** di tutte le malattie (non solo mentali)
- Capitolo F: Disturbi psichiatrici e comportamentali
- Uso principale: **codifica amministrativa** e statistica
- Meno dettagliato del DSM per aspetti clinici

Categorie principali (Capitolo F):

- F00-F09: Disturbi mentali organici
- F10-F19: Disturbi da uso di sostanze
- F20-F29: Schizofrenia e disturbi psicotici
- F30-F39: Disturbi dell'umore
- F40-F48: Disturbi nevrotici

- F50-F59: Sindromi comportamentali
- F60-F69: Disturbi di personalità
- F70-F79: Ritardo mentale
- F80-F89: Disturbi dello sviluppo psicologico
- F90-F98: Disturbi comportamentali ed emotivi infanzia/adolescenza
- F99: Disturbo mentale non specificato

ICD-11 (2018, in vigore dal 2022)

Novità rispetto a ICD-10:

- Maggiore compatibilità con DSM-5
- Organizzazione più razionale
- Rimozione di categorie obsolete
- Aggiunta di nuovi disturbi (es. gaming disorder)
- Formato digitale nativo
- Linee guida cliniche integrate

Capitolo 06: Disturbi Mentali, Comportamentali e del Neurosviluppo

Organizzato in modo più coerente e basato su evidenze scientifiche

7.4 Differenze tra DSM e ICD

ASPETTO	DSM-5-TR	ICD-11
Ente	American Psychiatric Association (USA)	Organizzazione Mondiale Sanità
Scopo principale	Clinico-diagnostico	Amministrativo-statistico (+ clinico)
Ambito	Solo disturbi mentali	Tutte le malattie
Dettaglio	Molto dettagliato	Meno dettagliato (ma migliorato in ICD-11)
Uso	Principalmente USA	Internazionale
Aggiornamento	Più frequente	Ogni 10-15 anni
Linguaggio	Inglese americano	Multilingue
Accessibilità	A pagamento	Gratuito online

Compatibilità:

- DSM-5 fornisce codici ICD-10-CM (versione USA di ICD-10)
- In Europa si usa principalmente ICD-10 (e ora ICD-11)
- Sempre maggiore convergenza tra i due sistemi

7.5 Vantaggi e Svantaggi dei Sistemi Classificatori

Vantaggi

1. Linguaggio Comune

- Permette comunicazione tra clinici
- "Schizofrenia" ha lo stesso significato per tutti
- Facilita consultazioni e trasferimenti di pazienti

2. Organizzazione delle Informazioni

- Raggruppa sintomi che co-occorrono
- Es: disturbi d'ansia condividono paura/ansia eccessive
- Facilita l'apprendimento e la diagnosi differenziale

3. Facilitazione della Ricerca

- Campioni omogenei per studi
- Confronto tra studi diversi
- Identificazione di fattori di rischio comuni

4. Differenziazione dei Trattamenti

- Alcuni disturbi rispondono a trattamenti specifici
- Es: SSRI efficaci per depressione e DOC
- Permette sviluppo di linee guida evidence-based

5. Affidabilità Migliorata

- Criteri operazionali aumentano accordo tra valutatori
- Kappa di Cohen migliorato rispetto a versioni precedenti
- Riduzione di diagnosi soggettive

6. Utilità Assicurativa/Legale

- Codici per rimborsi assicurativi
- Perizie medico-legali
- Riconoscimento invalidità

Svantaggi e Critiche

1. Troppe Categorie Diagnostiche

- DSM-5: **347 categorie**
- Rischio di "patologizzare" la normalità
- Inflazione diagnostica

- Categoria "disturbo senza specificazione" per casi ambigui

Esempio problema:

- Lutto prolungato diventa "disturbo da lutto persistente complicato"
- Rabbia intensa diventa "disturbo esplosivo intermittente"
- Dove finisce il normale disagio e inizia il disturbo?

2. Problema dell'Affidabilità

- Nonostante miglioramenti, l'affidabilità inter-rater (accordo tra valutatori) è ancora problematica per molti disturbi
- Due psicologi possono dare diagnosi diverse alla stessa persona
- Esempio: "disturbo bipolare" vs "disturbo borderline"

3. Mancanza di Validità di Costrutto

- I disturbi DSM corrispondono a entità reali o sono costrutti convenzionali?
- Non ci sono marker biologici per validare la maggior parte delle diagnosi
- La diagnosi si basa solo su sintomi comportamentali autoriferiti

4. Comorbidità Elevata

- Molti pazienti soddisfano criteri per **più disturbi contemporaneamente**
- Es: depressione + ansia + disturbo personalità
- Suggestisce che le categorie non sono veramente separate
- Forse i disturbi condividono processi sottostanti comuni

5. Eterogeneità all'Interno delle Categorie

- Persone con stessa diagnosi possono essere molto diverse
- Es: "Disturbo depressivo maggiore" richiede 5 su 9 sintomi → 256 combinazioni possibili!
- Due persone con "depressione" possono avere sintomi completamente diversi

6. Influenza delle Case Farmaceutiche

- Critiche su conflitti di interesse di membri delle commissioni DSM
- Espansione di categorie = espansione mercato farmaci
- Rischio di medicalizzazione di problemi esistenziali/sociali

7. Approccio Catoriale vs Dimensionale

- La natura usa categorie (depresso/non depressso)?
- O esistono continua (più o meno depressso)?
- DSM-5 ha introdotto valutazioni dimensionali ma rimane prevalentemente categoriale

8. Stigma

- Etichette diagnostiche possono stigmatizzare
- "Schizofrenico", "Borderline" diventano identità
- Effetto Rosenthal: le aspettative influenzano il comportamento

9. Riduzionismo Biologico Implicito

- Definizione di "disfunzione" suggerisce substrato biologico
- Trascura fattori sociali, culturali, esistenziali
- Modello bio-psico-sociale dichiarato ma non operazionalizzato

10. Dipendenza Culturale

- Criteri sviluppati in contesto USA
- Alcuni disturbi sono culture-bound
- Es: "taijin kyofusho" (Giappone) non ha equivalente in DSM

8. DISTURBI MENTALI SPECIFICI

Questa sezione approfondisce i disturbi mentali più rilevanti trattati nel corso, fornendo criteri diagnostici, caratteristiche cliniche e diagnosi differenziale.

8.1 Disturbi Depressivi

Disturbo Depressivo Maggiore (DDM)

Criteri Diagnostici (DSM-5-TR):

Almeno **5 dei seguenti sintomi** presenti per almeno **2 settimane**, con almeno uno tra (1) o (2):

1. **Umore depresso** per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno
2. **Marcata diminuzione di interesse o piacere** (anedonia) in tutte o quasi tutte le attività
3. Significativa perdita o aumento di peso (>5% in un mese) o diminuzione/aumento dell'appetito
4. Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno
5. Agitazione o rallentamento psicomotorio
6. Faticabilità o mancanza di energia
7. Sentimenti di autosvalutazione o colpa eccessiva
8. Ridotta capacità di pensare, concentrarsi o prendere decisioni
9. **Pensieri ricorrenti di morte**, ideazione suicidaria

Specificatori (importanti per diagnosi):

- Con ansia

- Con caratteristiche miste
- Con caratteristiche melancoliche
- Con caratteristiche atipiche
- Con caratteristiche psicotiche (congruenti o non congruenti all'umore)
- Con catatonia
- Con andamento stagionale

Epidemiologia:

- Prevalenza lifetime: 15-20%
- Più frequente nelle donne (2:1)
- Età media esordio: 20-30 anni

Decorso:

- Episodio singolo o ricorrente
- Durata media episodio non trattato: 6-9 mesi
- Rischio recidiva: 50% dopo primo episodio, 80% dopo terzo

Diagnosi Differenziale:

- Disturbo bipolare (necessità di escludere episodi maniacali/ipomaniacali)
- Disturbo depressivo persistente (distimia)
- Disturbo dell'adattamento con umore depresso
- Lutto normale vs disturbo da lutto prolungato
- Disturbi d'ansia (frequente comorbidità)
- Disturbo da sintomi somatici

Disturbo Depressivo Persistente (Distimia)

Caratteristiche:

- Umore depresso per **la maggior parte del giorno, per più giorni, per almeno 2 anni**
- Meno sintomi del DDM ma più cronico
- Può evolvere in DDM (depressione doppia)

8.2 Disturbi d'Ansia

I disturbi d'ansia condividono caratteristiche di **paura** (risposta emotiva a minaccia imminente) e **ansia** (anticipazione di minaccia futura) eccessive.

Disturbo di Panico

Criteri:

- **Attacchi di panico ricorrenti e inaspettati**

- Almeno un attacco seguito da **1 mese** (o più) di:
 - Preoccupazione persistente per altri attacchi
 - Preoccupazione per conseguenze dell'attacco
 - Cambiamento significativo comportamento correlato agli attacchi

Attacco di Panico (definizione): Periodo ben definito di intensa paura/disagio, con **almeno 4 dei seguenti sintomi**, che raggiunge il picco entro 10 minuti:

1. Palpitazioni, cardiopalmo, tachicardia
2. Sudorazione
3. Tremori fini o grandi scosse
4. Dispnea o sensazione di soffocamento
5. Sensazione di asfissia
6. Dolore o fastidio al petto
7. Nausea o disturbi addominali
8. Sensazioni di vertigine, instabilità, stordimento o svenimento
9. Brividi o vampate di calore
10. Parestesie (sensazioni di torpore o formicolio)
11. Derealizzazione o depersonalizzazione
12. Paura di perdere il controllo o impazzire
13. Paura di morire

Importante: Gli attacchi di panico possono verificarsi in molti disturbi d'ansia, non solo nel Disturbo di Panico

Agorafobia

Definizione: Ansia marcata in **almeno 2 di queste 5 situazioni**:

1. Uso trasporti pubblici
2. Trovarsi in spazi aperti (parcheggi, mercati, ponti)
3. Trovarsi in spazi chiusi (negozi, teatri, cinema)
4. Stare in fila o tra la folla
5. Essere fuori casa da soli

Caratteristica centrale: Paura che sia **difficile fuggire o ricevere aiuto** in caso di sintomi simil-panico

Comportamento: Evitamento delle situazioni, oppure affrontate con intensa ansia/paura o necessità di compagno

Disturbo d'Ansia Generalizzata (DAG)

Criteri:

- **Ansia e preoccupazione eccessive**, difficili da controllare
- Durata: **almeno 6 mesi**
- Riguardano **numerosi eventi o attività**

Associati ad almeno 3 dei seguenti sintomi:

1. Irrequietezza, sentirsi tesi o con nervi a fior di pelle
2. Facile affaticabilità
3. Difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria
4. Irritabilità
5. Tensione muscolare
6. Alterazioni del sonno

Caratteristica distintiva: La preoccupazione è:

- Cronica ed eccessiva
- Proiettata nel futuro
- Difficile da controllare
- Riguarda eventi quotidiani (lavoro, salute, finanze, famiglia)

Confronto con panico:

- DAG: preoccupazione ansiosa costante, diffusa
- Panico: episodi acuti di paura intensa

Fobie Specifiche

Definizione: Paura o ansia marcata verso un **oggetto o situazione specifica** (stimolo fobico)

Tipi:

- Animali
- Ambiente naturale (altezze, temporali, acqua)
- Sangue-iniezioni-ferite
- Situazionale (aereo, ascensore, spazi chiusi)
- Altro

Caratteristiche:

- Lo stimolo fobico provoca quasi invariabilmente paura/ansia
- Viene evitato attivamente o sopportato con intensa ansia
- Paura sproporzionata al pericolo reale
- Durata: tipicamente 6 mesi o più

Disturbo d'Ansia Sociale (Fobia Sociale)

Definizione: Paura o ansia marcata di **situazioni sociali** in cui la persona è esposta al possibile **giudizio degli altri**

Situazioni tipiche:

- Conversazioni
- Incontrare persone sconosciute
- Essere osservati mentre si mangia o beve
- Parlare di fronte ad altri (performance)

Timore centrale: Essere giudicati negativamente (ansioso, debole, pazzo, stupido, noioso, goffo)

Comportamento: Evitamento o sopportazione con intensa ansia delle situazioni sociali

8.3 Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD)

Criteri Diagnostici (DSM-5-TR)

Criterio A: Esposizione a Evento Traumatico

Esposizione a morte reale o minaccia di morte, grave lesione, violenza sessuale in uno (o più) dei seguenti modi:

1. Esperienza diretta dell'evento traumatico
2. Assistere di persona all'evento accaduto ad altri
3. Venire a conoscenza che l'evento traumatico è accaduto a familiare stretto o amico
4. Esposizione ripetuta o estrema a dettagli crudi dell'evento traumatico

Criterio B: Sintomi Intrusivi (almeno 1)

1. **Ricordi ricorrenti, involontari e intrusivi** dell'evento
2. **Sogni spiacevoli ricorrenti** correlati all'evento
3. **Reazioni dissociative (flashback)** in cui la persona sente o agisce come se l'evento si stesse ripresentando
4. **Disagio psicologico intenso** all'esposizione a fattori scatenanti interni o esterni
5. **Reazioni fisiologiche** a fattori scatenanti

Criterio C: Evitamento Persistente (almeno 1)

1. Evitamento di **ricordi, pensieri o sentimenti** angoscianti correlati all'evento
2. Evitamento di **fattori esterni** (persone, luoghi, conversazioni, attività, oggetti, situazioni)

Criterio D: Alterazioni Negative di Cognizioni e Umore (almeno 2)

1. Incapacità di ricordare aspetti importanti dell'evento (amnesia dissociativa)

2. **Convinzioni o aspettative negative persistenti** ("sono cattivo", "il mondo è pericoloso")
3. **Cognizioni distorte persistenti** sulle cause o conseguenze che portano a biasimare sé stessi o altri
4. **Stato emotivo negativo persistente** (paura, orrore, rabbia, colpa, vergogna)
5. **Marcata riduzione di interesse** o partecipazione ad attività significative
6. Sentimenti di **distacco o estraneità** verso gli altri
7. Persistente incapacità di provare **emozioni positive** (felicità, soddisfazione, amore)

Criterio E: Alterazioni dell'Arousal e della Reattività (almeno 2)

1. Comportamento irritabile ed esplosioni di rabbia
2. Comportamento spericolato o autodistruttivo
3. **Ipervigilanza**
4. **Esagerate risposte di allarme**
5. Problemi di concentrazione
6. Difficoltà del sonno

Durata: Sintomi per più di **1 mese**

Specificatori:

- Con sintomi dissociativi (depersonalizzazione o derealizzazione)
- Con espressione ritardata (criteri soddisfatti almeno 6 mesi dopo l'evento)

Diagnosi Differenziale PTSD

- **Disturbo Acuto da Stress:** sintomi simili ma durata 3 giorni - 1 mese
- **Disturbi dell'Adattamento:** fattore stressante non necessariamente traumatico, sintomi meno severi
- **Disturbo Ossessivo-Compulsivo:** pensieri intrusivi ma non correlati a trauma
- **Disturbi Depressivi:** possibile comorbidità, ma in PTSD sintomi legati al trauma

Strumenti di Valutazione PTSD

IES-R (Impact of Event Scale - Revised):

- 22 item
- 3 sottoscale: intrusione, evitamento, iperattivazione
- Autosomministrato
- Scoring: >33 probabile PTSD

8.4 Disturbi di Personalità

I disturbi di personalità sono caratterizzati da **pattern pervasivi, inflessibili e stabili** di esperienza interiore e comportamento che:

- Deviano dalle aspettative culturali
- Esordiscono nell'adolescenza o prima età adulta
- Sono stabili nel tempo
- Causano disagio o compromissione

Organizzazione in Cluster

Cluster A - Strano/Eccentrico:

Disturbo Paranoide:

- Sfiducia e sospettosità pervasive
- Sospetta sfruttamento, inganno, danno da parte degli altri
- Dubita della lealtà o affidabilità di amici
- Legge significati nascosti umilianti o minacciosi in eventi benigni
- Porta rancore, non perdona offese
- Percepisce attacchi al proprio carattere o reputazione non evidenti agli altri

Disturbo Schizoide:

- Distacco dalle relazioni sociali
- Gamma ristretta di espressioni emotive
- Non desidera né prova piacere da relazioni strette
- Preferisce attività solitarie
- Poco o nessun interesse per esperienze sessuali
- Apparentemente indifferente a lodi o critiche
- Freddezza emotiva, distacco o affettività appiattita

Disturbo Schizotipico:

- Deficit nelle relazioni strette
- Distorsioni cognitive o percettive
- Eccentricità comportamentali
- Idee di riferimento
- Convinzioni bizzarre o pensiero magico
- Esperienze percettive insolite
- Pensiero e linguaggio strani
- Sospettosità o ideazione paranoide
- Affettività inappropriata o ristretta
- Comportamento o aspetto strano, eccentrico
- Mancanza di amici stretti

- Ansia sociale eccessiva con connotazioni paranoide

Cluster B - Drammatico/Emotivo/Erratico:

Disturbo Antisociale:

- Inosservanza e violazione dei diritti degli altri (età ≥18 anni)
- Condotta antisociale prima dei 15 anni
- Ripetuta inosservanza di norme sociali (comportamenti suscettibili di arresto)
- Disonestà ripetuta (mentire, truffare)
- Impulsività o incapacità di pianificare
- Irritabilità e aggressività (colluttazioni, aggressioni fisiche)
- Noncuranza spericolata della sicurezza propria o altrui
- Irresponsabilità persistente (lavoro, obblighi finanziari)
- Mancanza di rimorso

Disturbo Borderline (DBP):

- Instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé, dell'affettività
- Marcata impulsività

Criteri (almeno 5):

1. **Sforzi disperati per evitare un abbandono** reale o immaginario
2. **Relazioni intense e instabili**, alternanza tra idealizzazione e svalutazione
3. **Disturbo dell'identità**: immagine di sé marcatamente e persistentemente instabile
4. **Impulsività** in almeno 2 aree autolesive (spese, sesso, abuso sostanze, guida spericolata, abbuffate)
5. **Ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari o autolesionismo**
6. **Instabilità affettiva** dovuta a marcata reattività dell'umore
7. **Sentimenti cronici di vuoto**
8. **Rabbia immotivata e intensa** o difficoltà a controllare la rabbia
9. **Ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi** transitori legati allo stress

Disturbo Istrionico:

- Emotività eccessiva e ricerca di attenzione
- Disagio quando non è al centro dell'attenzione
- Comportamento sessualmente seducente o provocatorio inappropriato
- Espressione emotiva rapidamente mutevole e superficiale
- Usa costantemente l'aspetto fisico per attirare l'attenzione
- Stile linguistico eccessivamente impressionistico e privo di dettagli
- Autodrammatizzazione, teatralità, espressione esagerata di emozioni
- Suggestionabilità

- Considera relazioni più intime di quanto siano

Disturbo Narcisistico:

- Grandiosità, bisogno di ammirazione, mancanza di empatia

Criteri (almeno 5):

1. Senso grandioso di importanza
2. Fantasie di successo, potere, bellezza, amore ideale illimitati
3. Credenza di essere speciale e unico
4. Richiede eccessiva ammirazione
5. **Senso di diritto** (aspettative di trattamento favorevole, obbedienza automatica)
6. **Sfruttamento interpersonale**
7. **Mancanza di empatia**
8. Invidia degli altri o credenza di essere invidiato
9. Comportamenti o atteggiamenti arroganti, presuntuosi

Cluster C - Ansioso/Pauroso:

Disturbo Evitante:

- Inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità al giudizio negativo
- Evita attività lavorative con contatti interpersonali per timore di critiche o rifiuto
- Riluttante a entrare in relazione se non sicuro di piacere
- Si mostra riservato nelle relazioni intime per timore di vergogna o ridicolo
- Preoccupato di essere criticato o rifiutato in situazioni sociali
- Inibito in situazioni interpersonali nuove per sentimenti di inadeguatezza
- Si vede come socialmente inetto, personalmente non attraente, inferiore agli altri
- Riluttante ad assumere rischi personali o impegnarsi in nuove attività per possibile imbarazzo

Disturbo Dipendente:

- Eccessivo bisogno di essere accudito, comportamento sottomesso e adesivo
- Difficoltà a prendere decisioni quotidiane senza rassicurazione eccessiva
- Bisogno che altri si assumano responsabilità per la maggior parte delle aree di vita
- Difficoltà ad esprimere disaccordo per timore di perdere supporto/approvazione
- Difficoltà ad iniziare progetti o fare cose autonomamente
- Si spinge a fare cose spiacevoli o degradanti per ottenere accudimento
- Sentimenti di disagio o impotenza quando solo
- Ricerca urgente di altra relazione quando una finisce
- Preoccupazione irrealistica di essere lasciato a badare a sé stesso

Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità: (diverso dal disturbo ossessivo-compulsivo!)

- Preoccupazione per ordine, perfezionismo, controllo mentale e interpersonale
- Preoccupato da dettagli, regole, liste, ordine, organizzazione, programmi
- Perfezionismo che interferisce con completamento compiti
- Eccessiva dedizione a lavoro e produttività a scapito di svago e amicizie
- Eccessivamente coscienzioso, scrupoloso, inflessibile su moralità, etica, valori
- Incapace di gettare oggetti consumati o senza valore
- Riluttante a delegare o lavorare con altri se non si sottomettono al suo modo di fare
- Adotta stile di vita parsimonioso per sé e altri
- Rigidità e testardaggine

Modello Alternativo DSM-5 (Sezione III)

Il DSM-5 propone un **modello alternativo** per i disturbi di personalità basato su:

1. Funzionamento della personalità (Criterio A):

- Identità
- Autodirezionalità
- Empatia
- Intimità Valutati su scala 0-4

2. Tratti patologici di personalità (Criterio B):

- 5 domini:
 - Affettività negativa
 - Distacco
 - Antagonismo
 - Disinibizione
 - Psicoticismo

Questo modello è **dimensionale** anziché categoriale, riflettendo meglio la realtà clinica

9. MODELLI ALTERNATIVI: HiTOP e RDoC

9.1 Classificazione Categoriale vs Dimensionale

Classificazione Categoriale (DSM attuale):

- Disturbo presente o assente (dicotomia)
- Esempio: "Il soggetto è iperteso?" → Sì/No
- **Vantaggio:** Semplicità diagnostica
- **Svantaggio:** Perdita di informazione, soglie arbitrarie

Classificazione Dimensionale:

- Disturbo su continuum
- Esempio: "In che punto di un continuum di misure ricade il valore della pressione del soggetto?"
- **Vantaggio:** Maggiore informazione, più vicino alla realtà clinica
- **Svantaggio:** Più complesso

Problema DSM: Altissima comorbidità suggerisce che le categorie non sono veramente separate

9.2 HiTOP (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology)

Definizione: Modello della **Tassonomia Gerarchica della Psicopatologia**, basato su dati empirici da migliaia di pazienti

Principio Fondamentale

HiTOP si concentra sulla **compresenza di sintomi e sindromi**. Le sindromi che si manifestano frequentemente in **comorbidità** sono raggruppate insieme, perché probabilmente condividono fattori di rischio o meccanismi sottostanti comuni.

Struttura Gerarchica

Sintomi → Sindromi → Sottofattori → Spettri → Superspettri

Esempio:

- Sintomi: tristezza, anedonia, insonnia
- Sindrome: Depressione Maggiore
- Sottofattore: Disturbi depressivi
- Spettro: Internalizzante
- Superspettro: Psicopatologia generale (fattore p)

I Sei Domini di HiTOP

1. Somatoforme

- Sintomi fisici senza causa medica
- Preoccupazione per salute
- Disturbo da sintomi somatici
- Ipocondria

2. Internalizzante

- **Paura:** disturbi d'ansia (panico, fobie)
- **Distress:** disturbi depressivi, PTSD Questi due sottofattori sono correlati ma distinguibili

3. **Disturbo del Pensiero**

- Sintomi psicotici
- Disorganizzazione del pensiero
- Esperienze insolite
- Schizofrenia e spettro

4. **Esternalizzante Disinibito**

- Impulsività
- Discontrollo comportamentale
- ADHD
- Disturbi da uso di sostanze
- Disturbi del comportamento dirompente

5. **Esternalizzante Antagonistico**

- Manipolazione
- Inganno
- Grandiosità
- Cercare attenzione
- Disturbo antisociale
- Disturbo narcisistico

6. **Distacco**

- Ritiro sociale
- Anedonia
- Affettività ristretta
- Disturbo schizoide
- Aspetti della schizofrenia negativa

Vantaggi di HiTOP

- Riflette meglio i **dati empirici** sulla comorbidità
- Più **informativo** del modello categoriale (fornisce profilo dimensionale)
- Migliore **validità predittiva** per decorso e trattamento
- Cattura meglio l'**eterogeneità** all'interno delle categorie DSM
- Guida meglio la **ricerca** su meccanismi comuni

Limiti di HiTOP

- Più **complesso** da usare clinicamente
- Meno familiare ai clinici
- Richiede valutazione dimensionale estesa
- Non sostituisce (ancora) DSM nella pratica clinica

9.3 RDoC (Research Domain Criteria)

Definizione: Criteri di Dominio di Ricerca (Research Domain Criteria), sviluppati dal **NIMH** (National Institute of Mental Health) USA

Obiettivo

Superare le **limitazioni del DSM** nella ricerca, sviluppando un sistema di classificazione basato su:

- **Neurobiologia**
- **Funzioni psicologiche** (non sindromi cliniche)
- **Dimensioni**, non categorie

Principio: I disturbi mentali sono disturbi del **funzionamento cerebrale**, quindi dovremmo classificare in base a **sistemi neurobiologici**, non in base a sintomi comportamentali

I Cinque Domini RDoC

1. Sistemi di Valenza Negativa (Negative Valence Systems)

- Risposta a situazioni avverse
- **Costrutti:**
 - Paura acuta
 - Ansia
 - Minaccia sostenuta
 - Perdita
 - Risposta frustrativa alla non-ricompensa

2. Sistemi di Valenza Positiva (Positive Valence Systems)

- Risposta a situazioni gratificanti
- **Costrutti:**
 - Approccio motivazionale
 - Risposta alla ricompensa
 - Apprendimento della ricompensa
 - Sforzo

3. Sistemi Cognitivi (Cognitive Systems)

- **Costrutti:**
 - Attenzione
 - Percezione
 - Memoria dichiarativa
 - Linguaggio
 - Funzioni esecutive
 - Memoria di lavoro

4. Sistemi per i Processi Sociali (Systems for Social Processes)

- **Costrutti:**
 - Affiliazione e attaccamento
 - Comunicazione sociale
 - Percezione e comprensione di sé
 - Percezione e comprensione degli altri

5. Sistemi di Arousal e Regolazione (Arousal/Regulatory Systems)

- **Costrutti:**
 - Arousal
 - Ritmi circadiani
 - Sonno-veglia

Unità di Analisi (Levels of Analysis)

Per ogni costrutto, RDoC esamina **7 livelli**:

1. **Geni**
2. **Molecole**
3. **Cellule**
4. **Circuiti neurali**
5. **Fisiologia**
6. **Comportamento**
7. **Auto-report**

Esempio - Costrutto "Paura Acuta":

- Geni: Varianti del gene del trasportatore della serotonina
- Molecole: Livelli di cortisolo
- Cellule: Neuroni dell'amigdala
- Circuiti: Connettività amigdala-corteccia prefrontale
- Fisiologia: Risposta galvanica della pelle, frequenza cardiaca
- Comportamento: Freezing, evitamento
- Auto-report: "Ho paura di..."

Focus di RDoC

I domini RDoC si concentrano su **fattori di rischio** trasversali a diversi disturbi:

- **Disfunzioni nella reattività a stimoli** (valenza positiva/negativa)
- **Disfunzioni nella sfera cognitiva** (attenzione, memoria, funzioni esecutive)
- **Disfunzioni nella sfera sociale** (riconoscimento emozioni, teoria della mente)

- **Incapacità di regolare emozioni o comportamento** (arousal, autocontrollo)

Vantaggi di RDoC

- Guida ricerca su **meccanismi biologici** dei disturbi
- Non vincolato da categorie DSM (può scoprire nuovi pattern)
- Promuove ricerca **transdiagnostica**
- Integra **livelli multipli** di analisi
- Orientato verso medicina di precisione

Limiti di RDoC

- **Non è un sistema diagnostico** clinico (è per la ricerca)
- Estremamente **complesso** e costoso da implementare
- Ancora lontano dall'applicazione clinica
- Riduzionismo biologico: rischio di trascurare fattori psicosociali
- Validazione empirica ancora parziale

9.4 Affidabilità e Validità dei Sistemi Diagnostici

Affidabilità Inter-Rater

Definizione: Grado di accordo tra due valutatori indipendenti che diagnosticano lo stesso paziente

Misurazione: Coefficiente **Kappa (κ)**

- $\kappa = 1$: Accordo perfetto
- $\kappa = 0$: Accordo casuale
- $\kappa < 0$: Disaccordo

Interpretazione:

- $\kappa > 0.80$: Ottimo
- $\kappa = 0.60-0.80$: Buono
- $\kappa = 0.40-0.60$: Moderato
- $\kappa < 0.40$: Scarso

Problema DSM-5: Molti disturbi hanno Kappa < 0.60 , indicando affidabilità problematica

Disturbi con migliore affidabilità:

- PTSD: $\kappa \approx 0.67$
- Disturbo bipolare I: $\kappa \approx 0.56$
- Disturbo depressivo maggiore: $\kappa \approx 0.28$ (!)

Disturbi con affidabilità più bassa:

- Disturbo d'ansia generalizzata: $\kappa \approx 0.20$
- Disturbi di personalità: $\kappa \approx 0.20-0.40$
- Disturbi misti ansia-depressione

Validità di Costrutto

Domanda: Le categorie diagnostiche DSM corrispondono a **entità reali**?

Tipi di Validità:

1. **Validità di contenuto:** I criteri coprono tutti gli aspetti del costrutto?
2. **Validità di costrutto:**
 - **Validità convergente:** Diagnosi correla con altri indicatori del disturbo?
 - **Validità discriminante:** Diagnosi distingue da altri disturbi?
3. **Validità predittiva:** Diagnosi predice decorso, risposta al trattamento?
4. **Validità eziologica:** Pazienti con stessa diagnosi hanno stesse cause?

Problema: Per la maggior parte dei disturbi DSM, la validità di costrutto è **limitata**:

- Non ci sono marker biologici validati
- Altissima eterogeneità all'interno delle categorie
- Elevata comorbidità suggerisce sovrapposizione dei costrutti
- Stessi trattamenti efficaci per disturbi diversi

Eccezioni: Disturbi neurocognitivi (es. Alzheimer) hanno migliore validità grazie a correlati neurobiologici

Correlazioni tra Misure

Relazione Positiva: Due misure dello stesso costrutto dovrebbero correlare positivamente

Relazione Negativa: Misure di costrutti opposti dovrebbero correlare negativamente

- Esempio: Estroversione e ritiro sociale

Relazione Nulla/Molto Debole: Misure di costrutti indipendenti non dovrebbero correlare

Problema DSM: Spesso le correlazioni non seguono questi pattern attesi, suggerendo problemi di validità

10. IL COLLOQUIO CLINICO

Il colloquio clinico è lo **strumento fondamentale** della psicologia clinica per la raccolta di informazioni, la costruzione della relazione terapeutica e la formulazione della diagnosi.

10.1 Analisi della Domanda

Che cos'è la Domanda?

La "domanda" non è solo il motivo esplicito per cui la persona si rivolge allo psicologo, ma include:

- **Domanda esplicita:** ciò che la persona dice di volere
- **Domanda implicita:** bisogni non verbalizzati
- **Domanda del committente:** chi invia la persona (famiglia, scuola, tribunale)
- **Domanda dello psicologo:** cosa ritiene necessario

Analisi della Domanda

Obiettivi:

1. Comprendere **chi chiede cosa a chi**
2. Identificare le **aspettative** della persona
3. Chiarire il **mandato** professionale
4. Negoziare **obiettivi** condivisi
5. Definire il **contratto** terapeutico

Domande guida:

- Chi ha fatto la richiesta di consultazione?
- Perché proprio ora?
- Cosa si aspetta la persona?
- Quali sono le motivazioni?
- Ci sono pressioni esterne?
- Qual è il livello di consapevolezza del problema?

10.2 Il Setting

Setting Spaziale

Definizione: Lo spazio fisico in cui avviene il colloquio

Elementi:

- Stanza dedicata, privata, isolata acusticamente
- Temperatura confortevole, illuminazione adeguata
- Disposizione sedie (non scrivania in mezzo!)
- Assenza di interruzioni
- Durata predefinita (tipicamente 50 minuti)
- Regolarità degli incontri

Funzione: Il setting crea un **contenitore** sicuro e prevedibile

Setting Relazionale

Definizione: Le regole implicite ed esplicite della relazione

Elementi:

- **Ruoli:** Psicologo e paziente/cliente
- **Confini:** Separazione tra vita professionale e privata
- **Riservatezza:** Segreto professionale
- **Regolarità:** Orari, frequenza
- **Contratto:** Obiettivi, metodi, costi

Setting Istituzionale

Il **contesto** in cui opera lo psicologo influenza profondamente il colloquio

Contesti diversi:

- **Studio privato:** Persona si rivolge volontariamente, paga
- **Ospedale:** Consultazione spesso su invio medico, gratuita
- **Scuola:** Minore inviato da insegnanti/genitori
- **Tribunale:** Perizia, obbligo
- **Azienda:** Valutazione o supporto lavorativo
- **Carcere:** Contesto coercitivo
- **Consultorio:** Servizio pubblico gratuito
- **Centro antiviolenza:** Trauma, emergenza
- **Casa di riposo:** Età avanzata, spesso deterioramento cognitivo

Ogni **contesto** influenza:

- **Motivazione** della persona
- **Aspettative**
- **Tipo di relazione** che si instaura
- **Obiettivi** possibili
- **Vincoli** (tempo, risorse, mandato istituzionale)

10.3 Tipologie di Intervista

Interviste Non Strutturate

Caratteristiche:

- Colloquio **aperto**, flessibile
- Lo psicologo segue il **flusso narrativo** della persona

- Domande aperte: "Mi parli di sé", "Cosa l'ha portata qui?"
- Permette **eloquio spontaneo**
- Osservazione di **stile comunicativo, affetti, transfert**

Vantaggi:

- Ricchezza di informazioni
- Comprensione globale della persona
- Costruzione relazione empatica
- Emergono aspetti inattesi

Svantaggi:

- Bassa affidabilità inter-rater
- Rischio di bias del clinico
- Tempo variabile
- Difficile confronto tra casi

Uso: Preferibile nelle fasi iniziali, in contesti psicoterapeutici, con persone collaborative

Interviste Strutturate

Caratteristiche:

- Domande **predefinite** da porre in **ordine fisso**
- Linguaggio standardizzato
- Criteri di codifica delle risposte
- Esempio: **SCID** (Structured Clinical Interview for DSM)

SCID (Structured Clinical Interview for DSM):

- Intervista diagnostica strutturata
- Organizzazione **gerarchica**: le risposte determinano domande successive
- Include **istruzioni per l'intervistatore** su quando sondare
- **Scala a tre punti** per quantificare gravità sintomi:
 - 1 = Assente o falso
 - 2 = Sotto-soglia
 - 3 = Soglia o vero
- Copre i principali disturbi DSM
- Durata: 1-3 ore a seconda dei moduli utilizzati

Vantaggi:

- **Alta affidabilità** inter-rater
- Diagnosi standardizzata

- Utile per ricerca
- Sistematicità (non si dimenticano aree)

Svantaggi:

- **Rigidità**
- Può ostacolare la relazione
- Tempo lungo
- Richiede training specifico
- Meno adatto a esplorare aspetti personali profondi

Uso: Ricerca, studi epidemiologici, contesti dove serve diagnosi standardizzata

Interviste Semistruzzurate

Caratteristiche:

- **Via di mezzo** tra strutturate e non strutturate
- Domande predisposte ma **flessibilità** nell'ordine e approfondimenti
- Possibilità di **esplorare** le risposte con domande aperte
- Copertura di **aree predefinite** ma con libertà di adattamento

Vantaggi:

- Compromesso tra affidabilità e ricchezza
- Adattabilità al paziente
- Costruzione relazione mantenendo sistematicità

Uso: Pratica clinica quotidiana, valutazioni diagnostiche in contesto terapeutico

10.4 Il Contesto e le Sue Implicazioni

Il **contesto** in cui avviene il colloquio determina:

1. Aspettative della persona:

- In ospedale: aspettativa medica (diagnosi, cura)
- In tribunale: aspettativa di giudizio
- In azienda: valutazione competenze
- In terapia privata: comprensione e cambiamento

2. Ruolo dello psicologo:

- Terapeuta vs Valutatore
- Alleato vs Perito
- Dipendente istituzione vs Professionista indipendente

3. Vincoli:

- Tempo limitato (consultazione singola vs percorso lungo)

- Obiettivi definiti da altri (perizia, invio)
- Risorse disponibili

4. **Relazione di potere:**

- Simmetrica (terapia privata volontaria)
- Asimmetrica (peritale, TSO, valutazione obbligatoria)

Esempio - Colloquio in Tribunale:

- Persona **non volontaria**
- Obiettivo: **valutazione**, non aiuto
- Psicologo al servizio del giudice, non del peritando
- **Minori garanzie di riservatezza** (relazione al giudice)
- Persona può essere **difensiva**, poco collaborativa
- Necessità di **chiarire il mandato** fin dall'inizio

Esempio - Colloquio in Consultorio:

- Servizio pubblico **gratuito**
- Persona spesso in **situazione di disagio socio-economico**
- Aspettative di **aiuto concreto** e immediato
- Setting meno "protetto" di studio privato
- Possibili **invii** ad altri servizi della rete

11. VALUTAZIONE PSICOLOGICA

La valutazione psicologica integra diversi strumenti per ottenere una comprensione approfondita della persona.

11.1 Questionari e Scale

I **questionari autosomministrati** e le **scale** sono strumenti standardizzati che permettono una valutazione quantitativa.

Caratteristiche

Vantaggi:

- Standardizzazione
- Velocità di somministrazione
- Possibilità di confronto con norme
- Monitoraggio nel tempo

Svantaggi:

- Risposte influenzate da desiderabilità sociale
- Comprensione linguistica necessaria
- Possibilità di simulazione/dissimulazione

Esempi di Scale

IES-R (Impact of Event Scale - Revised):

- **Scopo:** Misurare sintomi PTSD
- **Item:** 22
- **Sottoscale:**
 - Intrusione
 - Evitamento
 - Iperattivazione
- **Scoring:** >33 suggerisce probabile PTSD
- **Somministrazione:** Autovalutazione, riferita a evento traumatico specifico

ACE (Adverse Childhood Experiences):

- **Scopo:** Rilevare esperienze traumatiche infantili
- **Aree indagate:**
 - Abuso fisico, emotivo, sessuale
 - Trascuratezza fisica, emotiva
 - Disfunzioni familiari (violenza domestica, abuso sostanze genitore, malattia mentale genitore, separazione/divorzio, incarcerazione)
- **Scoring:** Punteggio 0-10 (somma esperienze presenti)
- **Evidenze:** Punteggio ACE elevato correlato con:
 - Problemi salute fisica (malattie cardiovascolari, tumori, diabete)
 - Problemi salute mentale (depressione, ansia, PTSD, suicidio)
 - Comportamenti a rischio (fumo, alcol, droghe)
 - Difficoltà relazionali

BDI-II (Beck Depression Inventory):

- **Scopo:** Misurare gravità sintomi depressivi
- **Item:** 21
- **Scoring:**
 - 0-13: Minimo
 - 14-19: Lieve
 - 20-28: Moderato
 - 29-63: Grave

STAI (State-Trait Anxiety Inventory):

- **Scopo:** Distinguere ansia di stato (temporanea) da ansia di tratto (caratteristica stabile)
- **Item:** 40 (20 stato + 20 tratto)

MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory):

- **Scopo:** Valutazione completa personalità e psicopatologia
- **Item:** 567
- **Scale:** Validità + 10 scale cliniche + scale supplementari
- **Tempo:** 60-90 minuti
- **Uso:** Contesti clinici, forensi, di selezione

11.2 Test Psicologici

I **test** richiedono somministrazione e interpretazione da parte di professionista formato.

Tipologie:

Test di Intelligenza:

- WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale)
- WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children)
- Matrici di Raven

Test Proiettivi:

- Rorschach
- TAT (Thematic Apperception Test)
- Test del disegno

Test Neuropsicologici:

- Valutazione funzioni cognitive specifiche
- Memoria, attenzione, funzioni esecutive, linguaggio

11.3 Tecniche Psicofisiologiche

Misurazione di **risposte fisiologiche** correlate a stati psicologici:

Parametri misurabili:

- Frequenza cardiaca
- Pressione arteriosa
- Risposta galvanica della pelle (GSR)
- Elettromiografia (EMG) - tensione muscolare
- Temperatura periferica
- Frequenza respiratoria

Uso:

- Ricerca su emozioni, stress, ansia
- Biofeedback
- Valutazione arousal in PTSD

11.4 Neuroimaging

Le **tecniche di neuroimaging** permettono di visualizzare struttura e funzione cerebrale.

Neuroimaging Strutturale

MRI (Magnetic Resonance Imaging - Risonanza Magnetica):

- Visualizza **struttura anatomica** del cervello
- Alta risoluzione spaziale
- Non invasivo, no radiazioni
- **Uso:** Rilevare lesioni, atrofie, anomalie strutturali

CT (Computed Tomography - TAC):

- Raggi X per immagini cerebrali
- Più veloce di MRI
- Uso principalmente per emergenze (emorragie, traumi)

Neuroimaging Funzionale

fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging):

- Misura **attività cerebrale** rilevando cambiamenti nel flusso sanguigno
- Risoluzione spaziale: millimetri
- Risoluzione temporale: secondi
- **Uso ricerca:** Correlati neurali di processi cognitivi, emozioni
- **Non uso diagnostico** in psicopatologia (non ci sono pattern patognomonic)

PET (Positron Emission Tomography):

- Traccianti radioattivi mostrano attività metabolica
- Uso clinico: Alzheimer, epilessia
- Uso ricerca: Neurotrasmettitori

EEG (Elettroencefalografia):

- Misura attività elettrica cerebrale
- Alta risoluzione temporale (millisecondi)
- Bassa risoluzione spaziale

- Uso: epilessia, disturbi del sonno, ricerca onde cerebrali

Limiti del Neuroimaging in Psicopatologia

Problemi:

1. **Nessun marker diagnostico specifico:** Non esiste pattern fMRI che diagnostichi depressione, schizofrenia, ecc.
2. **Elevata variabilità inter-individuale**
3. **Overlap tra disturbi:** Pattern simili in disturbi diversi
4. **Correlazione $\neq$ Causalità:** Attivazione anomala non significa che sia la causa del disturbo
5. **Campioni piccoli** nella ricerca
6. **Replicabilità** problematica di molti studi

Conclusione: Neuroimaging è prezioso per **ricerca** ma non per **diagnosi clinica** dei disturbi mentali (eccetto disturbi neurocognitivi con lesioni evidenti)

12. IL MODELLO OPERATIVO DIALOGICO

Il **Modello Operativo Dialogico** rappresenta un'alternativa epistemologica al Modello Operativo Medico, applicato alla Psicologia Clinica per la Salute.

12.1 Le Sei Prassi Dialogiche: Confronto con Modello Medico

MODELLO MEDICO	MODELLO DIALOGICO
Oggetto: UAF (Unità Anatomico-Funzionale)	Oggetto: Logos (linguaggio, processi discorsivi)
Sanità	Salute
Causa (noxa causalis)	Processo/Interazione
Guarigione	Cambiamento
1. Anamnesi	1. Sinesi
2. Diagnosi	2. Sceptsi
3. Terapia	3. Dieghesigenia
4. Prognosi	4. Anticipazione
5. Prevenzione	5. Promozione della Salute
6. Valutazione Efficacia (RCT)	6. Valutazione Efficacia (differenza configurazioni)

12.2 Sinesi

Etimologia: Dal greco *sýnesis* = comprensione, intelligenza, atto del mettere insieme

Definizione: Raccolta del logos, della configurazione discorsiva che descrive la salute della persona

Obiettivo

Comprendere **come la persona configura discorsivamente** la propria esperienza di salute/disagio attraverso:

- Le narrazioni che produce
- I significati che attribuisce
- Le modalità con cui descrive sé stesso, il mondo, gli altri

Differenza con Anamnesi

Anamnesi (modello medico):

- Raccolta di **fatti oggettivi** (sintomi, storia clinica)
- Focus sulla **noxa causalis** (cercare la causa)
- Domande chiuse, specifiche
- Obiettivo: individuare la malattia

Sinesi (modello dialogico):

- Raccolta di **configurazioni discorsive**
- Focus sul **logos** (come la persona parla della propria esperienza)
- Domande aperte, esplorative
- Obiettivo: comprendere come la persona costruisce la propria realtà di salute/disagio

Processo

1. **Ascolto attivo** del racconto della persona
2. **Attenzione** non solo ai contenuti ma alle **modalità discorsive**:
 - Quali parole usa?
 - Come struttura il racconto?
 - Quali metafore?
 - Quali repertori discorsivi prevalenti?
3. **Co-costruzione** del senso nell'interazione
4. Identificazione delle **tre dimensioni narrative**:
 - Io narrante
 - Esperto
 - Matrice Collettiva

Esempio

Anamnesi medica: "Da quanto tempo ha questi sintomi? Quanto sono intensi? Interferiscono con il lavoro?"

Sinesi dialogica: "Mi racconti come sta vivendo questo momento della sua vita... Come descriverebbe quello che le sta accadendo?" → Emergono non solo "sintomi" ma modalità di significare l'esperienza

12.3 Scepsi

Etimologia: Dal greco *sképsis* = osservazione, esame, considerazione

Definizione: Osservazione della configurazione discorsiva raccolta nella sinesi, che consente di definire le **strategie per intervenire**

Obiettivo

Analizzare la configurazione discorsiva per:

1. Identificare **repertori discorsivi** prevalenti (mantenimento vs generativi)
2. Comprendere la **coerenza narrativa**
3. Individuare **aperture** per nuove configurazioni
4. Definire **ipotesi di lavoro**

Differenza con Diagnosi

Diagnosi (modello medico):

- **Categorizzazione:** assegnare a una categoria DSM
- **Distinzione:** separare normale da patologico
- Focus su **deficit, disfunzione**
- Etichetta: "Lei ha un disturbo depressivo maggiore"

Scepsi (modello dialogico):

- **Comprensione processuale:** come funziona questa configurazione?
- **Osservazione:** quali possibilità di cambiamento?
- Focus su **risorse e vincoli** della configurazione attuale
- Non etichetta ma comprensione: "Noto che quando parla di... tende a..."

Analisi dei Repertori

Repertori di Mantenimento:

- "Sono fatto così" (essenzializzazione)
- "Non c'è niente da fare" (impossibilità)
- "È sempre stato così" (naturalizzazione) → **Bloccano** nuove configurazioni

Repertori Generativi:

- "Potrei provare a..." (possibilità)
- "In quella situazione ho fatto..." (agency)
- "Se facessi così, forse..." (esplorazione) → **Aprono** a nuove configurazioni

Scepsi identifica il **rapporto** tra questi repertori e individua dove intervenire

Formulazione

Non diagnosi ma **formulazione del caso**:

- Come questa persona configura discorsivamente la propria esperienza?
- Quali repertori prevalgono?
- Dove sono le **risorse** (repertori generativi disponibili)?
- Dove sono i **vincoli** (repertori di mantenimento rigidi)?
- Quali **nuove configurazioni** potrebbero essere più funzionali?

12.4 Dieghesigenia

Etimologia: Dal greco *diégēsis* = narrazione + *gēnesis* = generazione, origine

Definizione: **Generazione di una configurazione discorsiva "altra"** da quella disponibile al momento dell'intervento (produzione e applicazione del progetto educativo/terapeutico)

Obiettivo

Co-costruire con la persona nuove modalità di configurare discorsivamente la propria esperienza, più funzionali e generative

Differenza con Terapia

Terapia (modello medico):

- **Eliminare** la causa (noxa causalis)
- **Curare** i sintomi
- Focus sul **deficit** da rimuovere
- Paziente passivo riceve trattamento

Dieghesigenia (modello dialogico):

- **Generare** nuove configurazioni discorsive
- **Ampliare** il repertorio disponibile
- Focus sulle **possibilità** da creare
- Persona attiva co-costruttrice

Processo

Non è l'applicazione di una tecnica standard, ma un **processo dialogico** che:

1. **Parte** dalla configurazione attuale (sinesi + scepsi)
2. **Introduce perturbazioni**: domande, ridefinizioni, metafore alternative
3. **Esplora scenari alternativi**: "Cosa succederebbe se...?"
4. **Legittimare repertori generativi emergenti**
5. **Co-costruire nuove narrazioni** più funzionali
6. **Sostenere la stabilizzazione** di nuove configurazioni

Tecniche Dialogiche

Domande circolari:

- "Come pensa che suo marito vedrebbe questa situazione?" → Amplia prospettive

Ristrutturazione:

- "Mi sembra che quello che chiama 'essere debole' potrebbe anche essere visto come 'essere sensibile'" → Offre significato alternativo

Esternalizzazione:

- "Quando 'l'ansia' arriva, come risponde?" → Separa persona da problema, aumenta agency

Narrazione di eccezioni:

- "C'è stato un momento in cui questo non accadeva?" → Identifica risorse già presenti

12.5 Anticipazione

Etimologia: Dal latino *anticipare* = prendere prima, prevenire

Definizione: **Prospettare scenari discorsivi** che possono o meno realizzarsi a partire dalla configurazione discorsiva di salute osservata

Obiettivo

Non "prevedere" il futuro (come nella prognosi medica), ma **esplorare possibilità**:

- "Se continuasse questa configurazione, cosa potrebbe accadere?"
- "Se emergesse quella nuova configurazione, quali scenari si aprirebbero?"

Differenza con Prognosi

Prognosi (modello medico):

- **Previsione** del decorso basata su conoscenza della malattia
- "Decorso probabile": guarigione/cronicizzazione/peggioramento

- Basata su **leggi causali** e statistica

Anticipazione (modello dialogico):

- **Esplorazione** di scenari possibili, non previsione deterministica
- "Scenari potenziali" emergenti dalle configurazioni discorsive
- **Nessuna certezza**, solo possibilità
- Include l'effetto dell'**osservazione** (l'anticipazione stessa modifica il sistema)

Funzione Terapeutica

L'anticipazione ha valore **terapeutico** perché:

1. **Motiva** il cambiamento: mostrare conseguenze del mantenimento
2. **Orienta** le scelte: visualizzare esiti di configurazioni alternative
3. **Aumenta consapevolezza**: la persona vede dove sta andando

Non è fatalistica ("andrà così") ma **generativa** ("potrebbe andare così, ma possiamo...")

12.6 Promozione della Salute

Definizione: Prassi che contempla l'**interazione**. Rende disponibili determinate configurazioni discorsive piuttosto che altre

Obiettivo

Non "prevenire la malattia" ma **promuovere configurazioni di salute** a livello:

- Individuale
- Comunitario
- Sociale
- Politico

Differenza con Prevenzione

Prevenzione (modello medico):

- **Evitare** la noxa causalis
- **Primaria:** impedire insorgenza
- **Secondaria:** diagnosi precoce
- **Terziaria:** limitare complicanze
- Focus: **malattia** (evitarla)

Promozione Salute (modello dialogico):

- **Rendere disponibili** configurazioni discorsive di salute
- **Non gerarchica** (primaria/secondaria/terziaria)

- Focus: **salute** (generarla)
- **Empowerment**: aumentare controllo sulla propria salute
- **Azione su determinanti sociali**

Carta di Ottawa (1986) - Definizione

"La promozione della salute è il processo che consente alla gente di esercitare un **maggiore controllo** sulla propria salute e di **migliorarla**."

Cinque aree d'azione:

1. Costruire **politiche pubbliche** per la salute
2. Creare **ambienti favorevoli**
3. Rafforzare l'azione della **comunità**
4. Sviluppare **abilità personali**
5. Riorientare i **servizi sanitari**

Modalità Dialogiche

Interventi di promozione dialogica:

- **Educazione alla salute** (non solo informazione, ma costruzione di sensi condivisi)
- **Empowerment individuale e comunitario**
- **Partecipazione** (la comunità definisce i propri bisogni)
- **Advocacy** (dare voce a chi non ce l'ha)
- **Cambiamento sociale** (agire su determinanti strutturali)

12.7 Valutazione dell'Efficacia

Definizione: Rilevare la **differenza tra la configurazione discorsiva generata** e quella da cui si era partiti prima dell'intervento

Differenza con RCT

RCT (modello medico):

- Trial randomizzato controllato in doppio cieco
- Confronto gruppo sperimentale vs controllo
- **Misure oggettive** standardizzate
- **Eliminazione sintomi** come criterio successo
- Manuali di trattamento standardizzati

Valutazione dialogica:

- **Confronto** configurazione iniziale vs finale
- **Processo qualitativo** (non solo quantitativo)

- **Ampliamento repertorio** come criterio successo
- Ogni intervento è **unico**, non standardizzabile completamente

Criteri di Efficacia Dialogici

Un intervento è efficace quando:

1. **Repertori generativi** sono aumentati
2. **Repertori di mantenimento** sono diminuiti (o meno rigidi)
3. La persona ha **maggiore agency** (senso di capacità d'azione)
4. Le **configurazioni discorsive** sono più flessibili e adattive
5. La persona **si sente meglio** (riduzione sofferenza soggettiva)
6. **Funzionamento** in aree di vita importanti è migliorato

Metodi

Quantitativi:

- Questionari pre/post
- Scale di funzionamento
- Frequenza comportamenti target

Qualitativi:

- Analisi del cambiamento nelle narrazioni
- Repertori discorsivi utilizzati
- Modalità di significare l'esperienza

Integrati: Combinazione di metodi quantitativi e qualitativi

13. ARCHITETTURA DEI SERVIZI GENERATIVA

L'**Architettura dei Servizi Generativa** rappresenta un modello organizzativo per i servizi di salute che supera l'approccio tradizionale (nomotetico) orientandosi verso la promozione dialogica della salute.

13.1 Dall'Architettura della Cura all'Architettura Generativa

Architettura Nomotetica (Tradizionale)

Caratteristiche:

- **Focus:** Utente singolo
- **Modalità:** Ex-post (intervento dopo che il problema si è manifestato)
- **Attivazione:** L'utente va dal servizio

- **Prerequisiti:** Presenza di vincoli/obiettivi predefiniti
- **Relazione:** Asimmetrica (esperto → utente)
- **Servizi:** Frammentati, settoriali

Logica: Prevenzione della malattia-disagio

Limiti:

- Intervento tardivo
- Non agisce su cause strutturali
- Dipendenza dell'utente dal servizio
- Frammentazione (medico, psicologo, assistente sociale operano separatamente)

Architettura Generativa

Caratteristiche:

DIMENSIONE	ARCHITETTURA GENERATIVA
Focus	Sistema-paese (non solo utente)
Modalità	Ex-ante (promozione, non solo intervento su problema)
Attivazione	Il servizio va dall'utente (outreach)
Prerequisiti	Assenza di vincoli (se non gli obiettivi)
Relazione	Simmetria: condivisione del senso comune
Connessione servizi	Lavoro di rete come strategia per raggiungere obiettivo di cambiamento

Logica: Promozione della salute

Il Sistema-Paese

Definizione: Non solo l'individuo ma l'**intero tessuto sociale** come oggetto dell'intervento

Include:

- Politiche pubbliche
- Urbanistica
- Scuola
- Lavoro
- Ambiente
- Cultura
- Economia
- Sanità (come parte, non totalità)

Principio: La salute non si crea nei servizi sanitari ma nelle condizioni di vita quotidiana

13.2 La Risorsa e il suo Valore d'Uso ($0 < R < 1$)

Concetto di Risorsa

Risorsa: Qualsiasi bene/servizio/capitale (materiale o immateriale) a disposizione della comunità

Esempi:

- Spazio pubblico (parco, piazza)
- Centro aggregazione
- Associazione culturale/sportiva
- Competenze professionali
- Reti sociali
- Conoscenze locali

Dal Consumo all'Uso

Logica consumistica (tradizionale):

- La risorsa viene **consumata** dall'utente
- L'utente **dipende** dal servizio
- La risorsa si esaurisce nell'uso individuale
- Logica 0/1: o si ha o non si ha

Logica generativa:

- La risorsa ha **valore d'uso** (non di consumo)
- L'uso **genera** ulteriore risorsa
- La risorsa **aumenta** se condivisa
- **Logica $0 < R < 1$:** la risorsa non è mai né del tutto assente né del tutto presente, ma oscilla e può aumentare attraverso l'uso generativo

Valore d'Uso: $0 < R < 1$

Significato: Il valore della risorsa:

- Non è **0** (mai completamente assente)
- Non è **1** (mai completamente pieno/definitivo)
- **Oscilla** continuamente
- Può **crescere** attraverso l'uso condiviso e generativo

Esempio pratico:

Parco pubblico come risorsa:

- **Logica consumo:** il parco è uno spazio che gli utenti usano individualmente (valore fisso)
- **Logica generativa:**
 - Uso passivo (passeggiare) → R basso
 - Uso attivo (organizzare eventi comunitari) → R aumenta
 - Il parco diventa luogo di incontro, socializzazione, creazione legami
 - Nuovi utilizzi generano nuove possibilità
 - Il valore cresce attraverso l'uso collettivo

13.3 Interventi nell'Architettura Generativa

Principi Operativi

1. Intervento Ex-Ante

- **Prima** che il disagio diventi patologia
- **Agire sui determinanti** sociali della salute
- Creare condizioni favorevoli

2. Outreach (Il servizio va dall'utente)

- Non aspettare che le persone chiedano aiuto
- **Andare dove le persone sono** (scuole, quartieri, luoghi aggregazione)
- Abbattere barriere di accesso
- Intercettare bisogni sommersi

3. Assenza di Vincoli

- Flessibilità nell'intervento
- **Adattamento** al contesto specifico
- Non procedure standardizzate rigide
- Co-progettazione con la comunità

4. Simmetria

- Superamento relazione esperto → utente
- **Condivisione di senso comune**
- La comunità come esperta dei propri bisogni
- Professionista come facilitatore, non salvatore

5. Lavoro di Rete

- **Connessione** tra servizi diversi
- Coordinamento (sanitario, sociale, educativo, culturale, ecc.)
- Integrazione degli interventi

- Obiettivo comune condiviso

Esempi di Interventi Generativi

1. Progetto di rigenerazione urbana partecipata

- Comunità progetta riqualificazione spazio pubblico
- Non solo "estetica" ma creazione di luoghi di incontro
- Effetti: riduzione isolamento, aumento coesione sociale, empowerment

2. Orti urbani comunitari

- Spazi condivisi per coltivazione
- Non solo "produzione cibo" ma:
 - Socializzazione
 - Attività fisica
 - Trasmissione saperi
 - Integrazione intergenerazionale/interculturale

3. Gruppi di cammino

- Attività fisica collettiva
- Non solo "sport" ma:
 - Creazione legami sociali
 - Conoscenza territorio
 - Empowerment salute

4. Doposcuola comunitari

- Non solo "aiuto compiti" ma:
 - Coinvolgimento genitori
 - Valorizzazione competenze locali
 - Integrazione
 - Prevenzione dispersione scolastica

Differenza con Approcci Tradizionali

APPROCCIO NOMOTETICO	APPROCCIO GENERATIVO
Intervento su utente	Intervento su sistema
Ex-post (dopo problema)	Ex-ante (prima del problema)
Frammentato (settori separati)	Integrato (rete di servizi)
Utente passivo	Comunità attiva
Consumo risorse	Generazione risorse

APPROCCIO NOMOTETICO	APPROCCIO GENERATIVO
Dipendenza da servizi	Empowerment e autonomia
Focus su patologia	Focus su salute e benessere

14. CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE

La **capacità di intendere e volere** è un concetto giuridico fondamentale che determina l'**imputabilità** penale di una persona.

14.1 Definizioni Giuridiche

Etimologia

Intendere:

- Dal latino *intendere* = tendere verso, dirigere l'attenzione, comprendere
- **Capacità di intendere:** capacità di **comprendere** il significato delle proprie azioni e delle loro conseguenze
- Funzioni cognitive: consapevolezza, giudizio, comprensione causa-effetto

Volere:

- Dal latino *velle* = volere, desiderare
- **Capacità di volere:** capacità di **autodeterminarsi**, di controllare le proprie azioni secondo la propria volontà
- Funzioni volitive: controllo degli impulsi, libertà decisionale, capacità di conformare la condotta

Definizione Giuridica

Capacità di intendere: Attitudine a rendersi conto del **valore sociale** della propria condotta, distinguendo il lecito dall'illecito

Capacità di volere: Attitudine ad **autodeterminarsi**, ossia libertà di decidere se compiere o no un'azione

Requisito: Per essere **imputabili** (responsabili penalmente) è necessario possedere **entrambe** le capacità al momento del fatto

14.2 Vizio Totale e Parziale di Mente

Vitium (latino): difetto, alterazione, guasto

Art. 88 Codice Penale - Vizio Totale di Mente

"Non è imputabile chi, **nel momento in cui ha commesso il fatto**, era, **per infermità**, in tale stato di mente da **escludere** la capacità d'intendere o di volere."

Conseguenze:

- **Non imputabilità** (assoluzione per incapacità)
- Ma: possibile applicazione di **misura di sicurezza** se ritenuto socialmente pericoloso
- Es: ricovero in REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza)

Nota bene: Basta che manchi **una** delle due capacità (intendere o volere)

Art. 89 Codice Penale - Vizio Parziale di Mente

"Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da **scemare grandemente**, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, **risponde del reato commesso**; ma **la pena è diminuita**."

Conseguenze:

- **Imputabilità** (condanna)
- **Pena diminuita** (attenuante)
- Possibile applicazione di misura di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso

Cosa si intende per "Infermità"?

Interpretazione giuridica:

- **Malattie mentali** (psicosi, gravi disturbi dell'umore)
- **Disturbi di personalità gravi** (controverso, dipende dal caso)
- **Intossicazione da sostanze** (se cronica e grave)
- **Deterioramento cognitivo** (demenze)

Esclusi:

- Stati emotivi e passionali normali (rabbia, gelosia)
- Intossicazione volontaria (ubriachezza colpevole)
- Immaturità caratteriale
- Disturbi lievi

14.3 Perizia Psichiatrica

Quando si Richiede

Quando c'è **dubbio** sulla capacità di intendere e volere al momento del fatto, il giudice può disporre **perizia psichiatrica**.

Compiti del Perito

1. **Accertare** se al momento del fatto l'imputato era affetto da infermità mentale
2. **Valutare** se tale infermità ha:
 - **Escluso** (vizio totale) la capacità di intendere/volere
 - **Scemato grandemente** (vizio parziale) la capacità di intendere/volere
3. **Valutare pericolosità sociale** attuale

Perizia Retrospettiva

Problema: Valutare lo stato mentale **al momento del fatto** (spesso mesi/anni prima)

Metodi:

- Documentazione clinica precedente
- Testimonianze
- Ricostruzione anamnestica
- Valutazione attuale + inferenza sullo stato passato
- **Incertezza** intrinseca

Criticità

- **Soggettività:** Due periti possono giungere a conclusioni opposte
- **Pressioni:** Difesa vs Accusa hanno interessi contrapposti
- **Complessità:** Disturbi mentali non eliminano sempre capacità
- **Simulazione/dissimulazione:** Possibile in entrambe le direzioni
- **Diagnosi incerte:** DSM non è sufficiente per pronunciarsi su capacità giuridica

14.4 Imputabilità

Evoluzione Storica

Epoca Romana (Diritto Arcaico):

- Rapporto di **causalità** fatto-danno (responsabilità oggettiva)
- Distinzione *infantes* (bambini piccoli) da altri

Epoca Romana (Classica):

- Introduzione **elemento soggettivo** (colpa, negligenza)
- *Furiosus* (pazzo) non ha *mens* → non può essere colpevole
- *Demens/mente captus*: privazione della ragione

Epoca Romana (Tardo-classica):

- Distinzione *impuberes: infanti proximi* (vicini infanzia) vs *pubertati proximi* (vicini pubertà)
- Per essere responsabili serviva:
 - **Consilium** (capire natura dell'atto)

- **Consensus** (volere l'atto)

Medioevo:

- Concezione **morale e teologica**
- *Mens* presente o assente
- *Dementia* come mancanza ragione che Dio concede
- Libero arbitrio centrale

XIX Secolo:

- **Pothier** (1699-1772): incapacità valutata in concreto (caso per caso)
- Code Napoléon e Codice italiano 1865: esclusione responsabilità per infermità mentale
- Base per attuale art. 88-89 C.P.

Scuole Giuridiche

Scuola Classica:

- **Responsabilità** basata su **imputabilità**
- Presupposto: **libero arbitrio**
- Pena proporzionata al **reato** commesso
- Finalità pena: **retribuzione** e rieducazione

Scuola Positiva (Lombroso, Ferri, Garofalo):

- **Pericolosità sociale** più importante di imputabilità
- **Determinismo** (cause biologiche/sociali del crimine)
- Pena proporzionata alla **pericolosità**, non al reato
- Finalità pena: **difesa sociale**

Doppio Binario (sistema attuale italiano):

- Per imputabili: **pena**
- Per non imputabili pericolosi: **misura di sicurezza**
- Critiche: discrimina chi ha disturbo mentale (può essere detenuto più a lungo di chi non ce l'ha per stesso reato)

14.5 Manicomi e OPG

Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)

Funzione storica:

- Strutture per autori di reato prosciolti per vizio di mente
- Principio di **pericolosità sociale**

Condizioni:

- **Sovraffollamento** e reclusione degradante
- Condizioni **disumane**, abusi
- **Nessuna** funzione terapeutica reale
- Reclusione spesso **a tempo indeterminato** (basata su pericolosità, non su reato)
- Concetto positivista di **difesa sociale**

Gestione:

- Inizialmente: Ministero di Giustizia (carcere mascherato)
- Dal 2010: passa ad ASL

Critica agli OPG

- Violazione **diritti umani**
- **Doppia pena:** non imputabili ma detenuti (spesso più a lungo di imputabili per stesso reato)
- Assenza trattamenti adeguati
- Situazione igienico-sanitaria inaccettabile
- Condanne da **Corte Europea Diritti dell'Uomo**

14.6 REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza)

Legge 81/2014: Chiusura definitiva OPG e graduale passaggio a **REMS**

Caratteristiche REMS

Differenze rispetto a OPG:

OPG	REMS
Gestione Ministero Giustizia	Gestione Sistema Sanitario Nazionale
Grandi strutture (centinaia persone)	Piccole strutture (max 20 posti)
Carattere carcerario	Carattere sanitario
Tempo indeterminato	Permanenza temporanea ed eccezionale
Nessun trattamento	Trattamenti riabilitativi
Condizioni degradanti	Standard sanitari

Funzioni REMS:

1. **Cura e tutela** della persona con infermità mentale
2. **Contenimento** della pericolosità sociale (solo se necessario)
3. **Terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative**

4. **Transitorie:** preparazione ritorno in comunità

Principi:

- **Residualità:** ricovero solo se **unica misura** idonea
- **Territorialità:** vicino a residenza persona
- **Durata limitata:** non superiore al massimo di pena previsto
- **Progetto terapeutico** individualizzato

Criticità REMS

Problemi:

- Numero **insufficiente** di posti (liste d'attesa)
- Rischio di **permanenze prolungate** (contro spirito riforma)
- **Disparità regionali** nell'attuazione
- Difficoltà dimissioni per mancanza servizi territoriali adeguati

14.7 Casi Clinici

Caso Gustl Mollath (Germania)

Chi: Uomo tedesco

Accuse: Aggressione e danni, ma sosteneva teoria di riciclaggio bancario che coinvolgeva la moglie

Sentenza iniziale (2006):

- **Assolto penalmente** perché dichiarato "insano" (incompetenza criminale)
- Ma considerato **pericoloso** → internato in ospedale psichiatrico

Diagnosi psichiatrica:

- Disturbo paranoide
- "Sistema di deliri" con convinzioni di cospirazione finanziaria

Svolgimento successivo:

- Molte sue accuse (riciclaggio bancario) risultate **plausibili** con documenti successivi
- Nel 2013 corte ordina nuovo processo e lo rilascia
- Nel 2019 ottiene **~600.000€ di compensazione** dallo Stato bavarese per detenzione psichiatrica ingiusta

Riflessioni:

- **Pericolosità** dell'etichetta "paranoide"

- Confine labile tra delirio e verità scomoda
- Rischi dell'internamento basato su pericolosità presunta
- Bias confermativi nella valutazione psichiatrica

Caso Monia Bortolotti (Italia)

Chi: Donna italiana (Pedrengo, Bergamo)

Accuse: Infanticidio di due neonati, morti nel 2021-2022

Perizie psichiatriche:

- **3 psichiatri su 5** dicono era **totalmente incapace** di intendere/volere al momento fatti
- **Difesa e altri periti:** disturbo depressivo maggiore con caratteristiche **psicotiche**
- **Procura:** disturbo di personalità con tratti **borderline**, che NON esclude capacità

Sentenza (novembre 2024):

- **Assolta** per primo figlio ("fatto non provato")
- Per secondo figlio: riconosciuta **"totale incapacità"** di intendere/volere" al momento del fatto

Misura di sicurezza:

- Giudicata **socialmente pericolosa**
- Dovrà restare **almeno 10 anni in REMS**

Vizio di mente:

- Incapacità totale → **non imputabilità** penale
- Ma: misura di sicurezza per pericolosità

Riflessioni:

- **Disaccordo** tra periti su diagnosi e capacità
- Depressione psicotica vs disturbo personalità: rilevanza per imputabilità
- **Doppio binario:** non colpevole ma detenuta (10 anni!)
- Pericolosità: come si valuta? Su quali basi?
- Stigma: "pericolosa" per 10 anni per fatti commessi in stato psicotico

Riflessioni Comuni ai Casi

1. **Soggettività valutazioni:** Periti diversi → conclusioni opposte
2. **Pericolosità sociale:** Concetto vago, stigmatizzante, difficile da prevedere
3. **Internamento:** Può durare più della pena prevista per il reato
4. **Diagnosi ≠ Incapacità:** Avere disturbo mentale non significa automaticamente incapacità

5. **Bias:** Rischio di circolarità (ha ucciso → deve essere pazzo → quindi incapace)
-

15. CONTESTI APPLICATIVI

15.1 Diagnosi Organizzativa

La **diagnosi organizzativa** applica principi della psicologia clinica al contesto delle organizzazioni (aziende, enti, istituzioni).

Obiettivi:

- Analizzare **funzionamento** dell'organizzazione
- Identificare **problemi** (conflitti, inefficienze, malessere)
- Comprendere **clima** e **cultura** organizzativa
- Valutare **benessere** lavoratori
- Proporre **interventi** di miglioramento

Strumenti:

- Questionari di clima organizzativo
- Interviste a dipendenti/manager
- Focus group
- Osservazione sul campo
- Analisi documenti aziendali
- Analisi rete relazioni

Applicazione modello dialogico:

- Sinesi: raccolta configurazioni discorsive sull'organizzazione
- Scepsi: analisi repertori prevalenti (es. "Qui è sempre stato così" → repertorio mantenimento)
- Dieghesigenia: co-costruzione nuove configurazioni organizzative più funzionali

15.2 Valutazione del Rischio di Infortunio

Valutazione psicosociale del rischio:

Fattori psicologici:

- **Stress** lavorativo
- **Carico cognitivo** eccessivo
- **Monotonia** compiti
- **Ritmi** di lavoro insostenibili

Fattori organizzativi:

- Scarsa **comunicazione**
- Conflitti
- Mancanza **supporto** sociale
- **Ambiguità** di ruolo
- **Sovraccarico** o sottocarico lavorativo

Conseguenze:

- Aumento **infortuni**
- **Errori** umani
- **Assenteismo**
- **Turnover**
- Ridotta **produttività**

Interventi:

- Formazione sicurezza
- Miglioramento organizzazione lavoro
- Supporto psicologico
- Promozione benessere organizzativo

15.3 Efficienza Gestionale

Psicologia e gestione:

Aree di intervento:

1. **Leadership:** Stili di leadership efficaci
2. **Motivazione:** Strategie per motivare dipendenti
3. **Team building:** Costruzione gruppi di lavoro efficaci
4. **Comunicazione:** Miglioramento comunicazione interna
5. **Change management:** Gestione cambiamenti organizzativi
6. **Gestione conflitti:** Mediazione e risoluzione
7. **Work-life balance:** Prevenzione burnout

Modello dialogico applicato:

- Focus su **configurazioni discorsive** organizzative
- Promozione **repertori generativi** ("Possiamo innovare")
- Riduzione repertori mantenimento ("Si è sempre fatto così")
- **Empowerment** lavoratori
- Approccio **partecipativo** al cambiamento

CONCLUSIONI

Gli appunti hanno coperto l'intero programma del corso di **Psicologia Clinica per la Salute**, strutturato in tre parti fondamentali:

Parte A - Fondamenti Epistemologici: Abbiamo esplorato i livelli di realismo, l'evoluzione dei paradigmi scientifici, il principio di indeterminatezza, e soprattutto la distinzione epistemologica tra Sanità e Salute. Questa distinzione è cruciale per comprendere il passaggio dal modello meccanicistico al modello interazionista/dialogico.

Parte B - Dal Modello Medico alla Psicopatologia: Abbiamo ripercorso la storia del modello medico, le sue applicazioni alla psicopatologia, i sistemi di classificazione (DSM-5-TR, ICD), i disturbi mentali specifici, e i modelli alternativi (HiTOP, RDoC) che cercano di superare i limiti dell'approccio categoriale.

Parte C - Strumenti Operativi: Abbiamo approfondito gli strumenti della pratica clinica (colloquio, valutazione), il modello operativo dialogico con le sue sei prassi, l'architettura dei servizi generativa, e temi giuridici come la capacità di intendere e volere.

Il filo conduttore è stato il **passaggio da un paradigma meccanicistico-causale a un paradigma interazionista-dialogico**, che richiede un cambio di prospettiva radicale: dalla malattia alla salute, dalla cura alla promozione, dall'oggetto (UAF) al processo (Logos), dalla diagnosi alla comprensione configurazionale.

Questo approccio dialogico non nega l'utilità del modello medico in certi contesti (patologie con chiara base organica), ma evidenzia i suoi limiti quando applicato alla salute mentale e alla complessità dell'esperienza umana.

La salute, in questa prospettiva, emerge come configurazione discorsiva co-costruita nell'intersezione tra lo narrante, Esperto e Matrice Collettiva, in un processo dialogico continuo e sempre situato nel momento Kairologico.
